

PLANO ESTRATÉGICO CONSOLIDADO | VERSÃO 3.0 | OUTUBRO DE 2026

Plano de Marketing, Branding e Growth

Marketing tratado como sistema de engenharia: evidência, mecanismo, decisão e ciclo de feedback. Dossiê do cliente, mercado, ICP, marca e linguagem, plano diretor de growth, ecossistema digital de inteligência de marketing, equipe interna e orçamento para a

LIVRO 1 Marketing

LIVRO 2 Branding

LIVRO 3 Growth e Ecossistema

Preparado para a Diretoria do Hospital e Maternidade São Paulo

Cacoal, Rondônia | www.hmsaopaulo.com.br

COMO LER ESTE PLANO

Sumário

Resumo executivo	3
Glossário de termos em inglês	5
Premissas adotadas e pontos a validar	7
Dossiê de compreensão do cliente	8
Concorrência privada na praça	16
Mercado dimensionado: TAM, SAM e SOM	18
Natalidade na Macrorregião II	20
ICP, consumidor e jornada	21
Brand equity, identidade e posicionamento	23
Linguagem de comunicação e guia de voz	25
North Star, funil e atribuição	27
Plano diretor de growth: 90, 120, 240 dias e 1 ano	28
Transformação do Ecossistema Digital	34
Equipe interna de marketing: recrutamento, seleção e treinamento	40
Orçamento, OKRs, calendário e riscos	43
Conclusão e decisões pedidas	47

COMO ESTE DOCUMENTO FOI CONSTRUÍDO

Método: cadeia ECIDT (Evidência, Interpretação, Decisão, Teste). Cada número traz um rótulo: **[FATO]** lido em fonte primária; **[DADO]** fonte oficial ou terceira confiável; **[ESTIMATIVA-MÉTODO]** calculado com fórmula e faixa; **[BENCHMARK]** referência de mercado a calibrar; **[HIPÓTESE]** inferência a validar; **[SEM ACESSO]** fonte não acessada; **[RECOMENDAÇÃO]** decisão defendida.

A única fonte sobre o cliente são canais digitais públicos e fontes oficiais. Brand equity, demanda, margem e perfil do paciente são triangulados, não medidos.

CONVENÇÃO DE PERÍODOS (CICLO DE 30 DIAS)

O fluxo de caixa do hospital se organiza em ciclos de 30 dias; por isso toda grandeza traz a unidade de tempo explícita: **/mês** (por mês, ciclo de 30 dias), **/ano** (por ano, 12 meses) e **(estoque)** (população ou capacidade em uma data, sem período). Quando um dado é anual, o equivalente mensal vem ao lado (anual dividido por 12).

PARA A DIRETORIA, EM UMA PÁGINA

Resumo executivo

TESE

O Hospital e Maternidade São Paulo (HMSP) tem mais de cinco décadas de presença em Cacoal e é conduzido desde 1996 por um grupo de médicos sócios **[FATO: site institucional, 02/10/2026]**. Atua em uma macrorregião com 735.852 habitantes **(estoque)** **[DADO: SESAU/RO, Censo 2022]**. A vantagem do hospital não é tamanho: é ser a casa de médicos locais e de famílias da praça. Este plano organiza esse capital em um sistema de crescimento: marca de família com linguagem única, rede de médicos e empresas parceiras, equipe interna de marketing e um ecossistema digital de inteligência que coloca toda a informação diante da diretoria.

735.852

habitantes na Macrorregião II
(estoque) **[DADO]**

214.252

alcançe ativo, 29,1% da Macro II
(estoque) **[HIPÓTESE]**

**128 a
564/mês**

pacientes únicos privados
(SOM de planejamento);
equivale a 1.540 a 6.770/ano

+45/mês

nascimentos ocorridos em
Cacoal acima dos residentes
(540/ano, 2024) **[DADO]**

As 4 apostas dos próximos 12 meses

#	Aposta	Por que ganha aqui	Prova em 90 dias
1	Fundação de captura e dados: número e CTA por intenção, WhatsApp triado, GA4, Perfil da Empresa, banco de dados e CRM	A medição por origem e intenção é o que permite decidir onde investir cada real do ciclo de 30 dias.	100% dos contatos com origem e intenção registradas; mediana da 1ª resposta medida.
2	Marca de família e linguagem única, ancoradas em maternidade e pediatria (ICP-1)	Obstetrícia, ginecologia, pediatria e Parto Humanizado já existem; mães de 25 a 39 anos concentram o plano.	Brand book v1 aprovado; 100 gestantes com contato registrado; visitas e curso de gestantes agendados.
3	Rede B2B2C: médicos parceiros, convênios corporativos e agro	Gestão médica desde 1996, corpo clínico com CRM/RQE e economia regional do café (IG Matas de Rondônia).	10 médicos parceiros em reunião; 5 empresas ou cooperativas com proposta (até o dia 120).
4	Equipe interna de marketing e Ecossistema Digital de Inteligência	Informação integrada (CRM, banco de dados, IA, intranet, BI) para decisões semanais da diretoria.	Coordenação e núcleo da equipe contratados; ferramentas escolhidas; núcleo de dados no ar.

O que NÃO fazer

- Mídia paga antes da instrumentação (balde furado). Chatbot clínico ou qualquer IA com dado de saúde sem contrato, base legal e revisão humana.
- Disputar urgência regulada ou copiar o posicionamento de trauma e ortopedia de concorrentes privados. Superlativos como “o melhor” ou “referência” sem prova (revisão CFM).
- Imagens de pacientes sem TCLE. Promessa de resultado clínico. Lista de convênios sem confirmação mensal.

Números em faixa: conservador, base e agressivo

Indicador (unidade de tempo explícita)	Conservador	Base	Agressivo
Atendimentos adicionais no mês 12, todos os canais /mês [ESTIMATIVA-MÉTODO]	116	232	372
Atendimentos adicionais acumulados em 12 meses [ESTIMATIVA-MÉTODO]	698	1.396	2.233
SOM de pacientes únicos privados /mês (e /ano) [ESTIMATIVA-MÉTODO]	128 (1.540)	303 (3.640)	589 (7.070)
Custo recorrente da estrutura no mês 12 /mês [HIPÓTESE]	R\$ 70 mil	R\$ 95 mil	R\$ 109 mil
Investimento pontual de implantação (uma vez) [HIPÓTESE]	R\$ 110 mil	R\$ 110 a 235 mil	R\$ 235 mil

RISCOS CRÍTICOS E 3 PASSOS DOS PRÓXIMOS 14 DIAS

Riscos: (1) mercado privado alcançável estreito (25.700 a 47.100 pessoas **(estoque)**), o que exige convênios corporativos e alcance regional; (2) capacidade da maternidade ainda não mapeada; (3) conformidade CFM e LGPD; (4) dependência de um programador externo único.

Passos: (a) dias 1 a 7: nomear patrocinador e encarregado de dados, unificar canais e abrir as vagas de coordenação e programação; (b) dias 1 a 14: GA4, GTM, Perfil da Empresa, WhatsApp Business com etiquetas e planilha-CRM; (c) dias 7 a 14: agenda das oficinas do mapa de situação e início de 15 entrevistas.

VOCABULÁRIO DE MARKETING

Glossário de termos em inglês

Termos usados ao longo do plano, com definição operacional para o contexto hospitalar. A coluna “No HMSP” diz como o termo aparece na prática.

Termo	Significado	No HMSP
ICP (Ideal Customer Profile)	Perfil do cliente com maior encaixe entre necessidade, acesso e valor.	Quatro ICPs: família do primeiro filho, adulto 40-69, empresa/cooperativa, médico parceiro.
TAM, SAM, SOM	Mercado total, alcançável e fatia realisticamente atendível.	Macro II; alcance ativo com acesso privado; pacientes únicos por ano.
North Star Metric	A métrica única que melhor resume o valor entregue.	Jornadas qualificadas concluídas por mês (proxy: TRJA).
Guard-rail	Limite que pausa a escala se uma métrica crítica piorar.	Tempo de resposta, NPS, conformidade, capacidade.
Funnel e AARRR	Funil: Acquisition, Activation, Revenue, Retention, Referral.	Aquisição, ativação, receita, retenção e indicação.
Growth loop	Ciclo em que a saída de uma etapa vira entrada da seguinte.	Busca local, B2B2C, família e empresas.
Growth plan / plano diretor	Plano integrado de crescimento com metas, pilares, canais e gates.	Capítulo II.
B2B2C	Chegar ao paciente por quem já tem sua confiança.	Médicos, empresas, cooperativas e planos.
CTA (Call to Action)	Chamada que convida a uma ação específica.	Um link de WhatsApp por serviço e origem.
Lead e lead qualificado	Contato que demonstrou interesse; o qualificado tem intenção verificada.	Contato com intenção registrada no CRM.
CPL e CAC	Custo por lead e custo de aquisição de cliente.	Custo por contato qualificado: R\$ 35 a 70 [HIPÓTESE] .
Conversion rate	Percentual que avança de uma etapa à seguinte.	Contato para comparecimento: 25 a 40% [HIPÓTESE] .
No-show	Ausência a consulta ou exame agendado.	Alvo do lembrete 24 h antes.
CRM	Customer Relationship Management: base única de contatos e pipeline.	Planilha no dia 30; CRM piloto até o dia 120.
SLA (Service Level Agreement)	Prazo prometido de serviço.	1ª resposta em até 5 min em horário comercial.
NPS	Índice de recomendação de 0 a 10.	NPS de duas perguntas por WhatsApp, com opt-in.
Opt-in e opt-out	Consentimento para receber comunicação e retirada dele.	Comunicação promocional separada da assistencial.
Handoff	Passagem de uma conversa da automação para um humano.	Obrigatório em todo fluxo de WhatsApp.
Touchpoint e moment of truth	Ponto de contato; momento que decide a percepção da marca.	1º contato e 1ª recepção.
Job-to-be-done (JTBD)	O progresso que a pessoa quer fazer ao contratar um serviço.	“Parto seguro e perto de casa.”
Brand equity	Valor que a marca acrescenta ao serviço (Aaker, Keller).	Scorecard de seis dimensões, 5,7 de 10 [HIPÓTESE] .
Brand book	Manual de marca: identidade, voz, regras de uso e modelos.	Entregável do dia 90 (v1).
Attribution (first e last touch)	Regra que credita o resultado ao primeiro ou ao último contato.	Atribuição administrativa, nunca causalidade clínica.

Termo	Significado	No HMSP
UTM	Parâmetros de URL que identificam origem, meio e campanha.	Planilha de nomenclatura padronizada.
SEO local	Otimização para busca por proximidade (Google Maps).	Perfil da Empresa e páginas de serviço.
Ecossistema digital	Conjunto integrado de canais, dados, CRM, IA, intranet e BI.	Capítulo 12.
API e webhook	Interfaces que fazem sistemas conversarem e se avisarem de eventos.	Ligam WhatsApp, CRM, banco de dados e agenda.
BSP	Provedor oficial de acesso à API do WhatsApp Business Platform.	Parceiro que opera o canal oficial com fila e SLA.
RAG	IA que responde consultando uma base de conteúdo aprovado.	Assistente de FAQ administrativa, sem dado clínico.
BI e dashboard	Painel de indicadores; Business Intelligence.	Painéis em três camadas, com atualização contínua.
DPO / Encarregado, RIPD	Responsável por dados pessoais; relatório de impacto à proteção de dados.	Nomeação no dia 7; RIPD por fluxo.
SSO e MFA	Acesso único com verificação em duas etapas.	Entra ID (Microsoft) em todas as ferramentas.
Pre-mortem e red team	Imaginar a falha antes dela; atacar o próprio plano.	Seção de riscos.
Churn e retention	Perda de clientes; manutenção deles.	Taxa de retorno em 90 dias.
Make x buy	Decidir entre fazer internamente ou contratar.	Equipe interna; só o programador fullstack é externo.

PARTE 0 | PREMISSAS DE TRABALHO

Premissas adotadas e pontos a validar

TESE

Quatro documentos-fonte foram lidos e consolidados. Eles apontam a mesma direção (sistema de captura, funil mensurável, conformidade com LGPD e CFM) e trazem alguns números com mais de uma versão pública. A tabela registra a premissa adotada em cada caso e o que a diretoria pode confirmar para elevar a confiança do plano.

Tema	Premissa adotada neste plano	Validação sugerida com a diretoria
Marcos históricos	Fundação em 1975, ampliação em 1983 e gestão por médicos sócios desde 1996 (site institucional).	Confirmar o ato de fundação e a narrativa oficial; só então usar “mais de 50 anos” em todas as peças.
População da Macro II	735.852 habitantes (estoque) (IBGE 2022, SESAU/RO), 34 municípios. Outras publicações regionais citam 781.170 e 783.830.	Manter 735.852 como base e tratar a variação como faixa de incerteza.
População de Cacoal	86.887 (estoque) (Censo 2022). O portal municipal exibe 98.884 como estimativa de 2026.	Usar 86.887 como observação e 98.884 como sensibilidade.
Capacidade	CNES: 23 leitos existentes (fotografia cadastral, competência a confirmar).	Diretoria clínica informa leitos, salas e partos / mês reais.
North Star	Duas camadas: TRJA (mensurável sem dado clínico) e jornada qualificada concluída (alvo de negócio).	Aprovar as definições operacionais no mapa de situação.
Convênios	Lista textual por plano e serviço, com data, confirmada todo mês.	Receber a relação vigente de operadoras e coberturas.
Canais de contato	Um número-mãe por intenção, formato padronizado e teste periódico dos formulários.	Escolher os números e os responsáveis por canal.
Mercado privado	SAM 25.700 a 47.100 (estoque) e SOM 1.540 a 6.770 pacientes únicos / ano : planejamento de baixa confiança, não meta.	Entregar o mix de pagadores dos últimos 12 meses (por ciclo de 30 dias).

LIVRO 1 | MARKETING | CAPÍTULO 1

Dossiê de compreensão do cliente

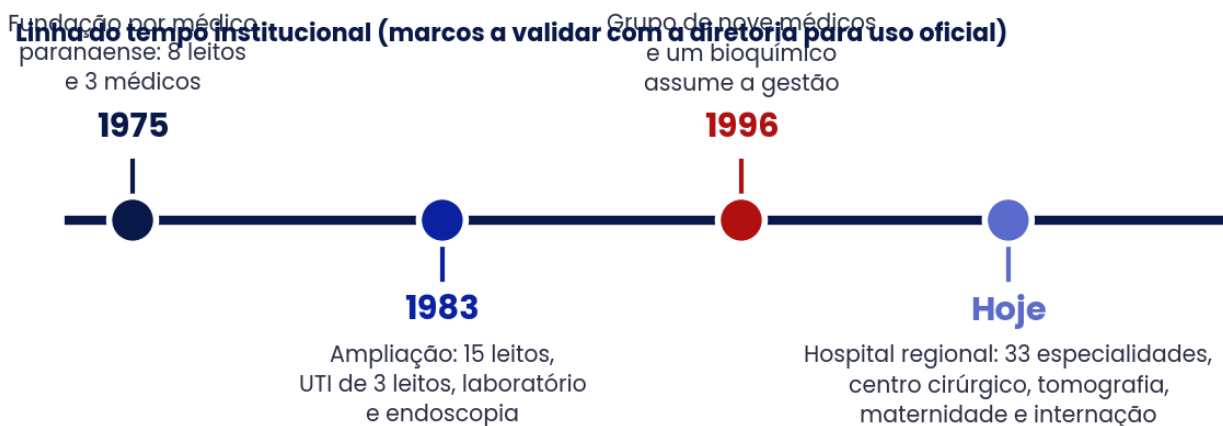
TESE

O HMSP nasceu pequeno (8 leitos, 3 médicos) e cresceu junto com Cacoal até se tornar um hospital regional conduzido por médicos sócios. Sua comunicação é afetiva (“zele”, “Conte com a gente. Você não está sozinho”) e seu ativo mais raro é a confiança construída por médicos da região. Este dossiê reúne, em um só lugar, quem é o hospital, de onde vem, o ambiente em que atua, a situação em que está e a praça que serve, como base comum para todas as decisões do plano.

1.1 Ficha institucional

Dimensão	Informação	Rótulo
Natureza	Hospital geral privado, conduzido por grupo de médicos sócios	[FATO]
Localização	Cacoal, Rondônia: Região de Saúde Café, Macrorregião de Saúde II	[DADO]
Cadastro	CNES 2784637; 23 leitos existentes no módulo consultado (fotografia cadastral)	[DADO]
Serviços	Consultas, centro cirúrgico (eletivas, urgência e emergência), internação, pronto atendimento, maternidade e tomografia	[FATO]
Especialidades	33 listadas, incluindo cardiologia, nefrologia, cirurgia vascular, ortopedia, obstetrícia, pediatria, cardiopediatria, genética e psiquiatria	[FATO]
Corpo clínico	Profissionais identificados com fotos, CRM e, em geral, RQE	[FATO]
Transparência de acesso	Informa os limites do pronto atendimento ao lado da oferta (sem check-up eletivo, sem observação acima de 24 h, sem garantia de vaga)	[FATO]
Reputação pública (referência de partida)	Google Maps 3,9/5 em 137 avaliações; Doctoralia 5/5 em 19 opiniões. São universos diferentes: nunca somar médias; exibir n, plataforma e janela	[FATO]
Redes sociais	Instagram e Facebook ativos; métricas não acessadas nesta rodada	[SEM ACESSO]

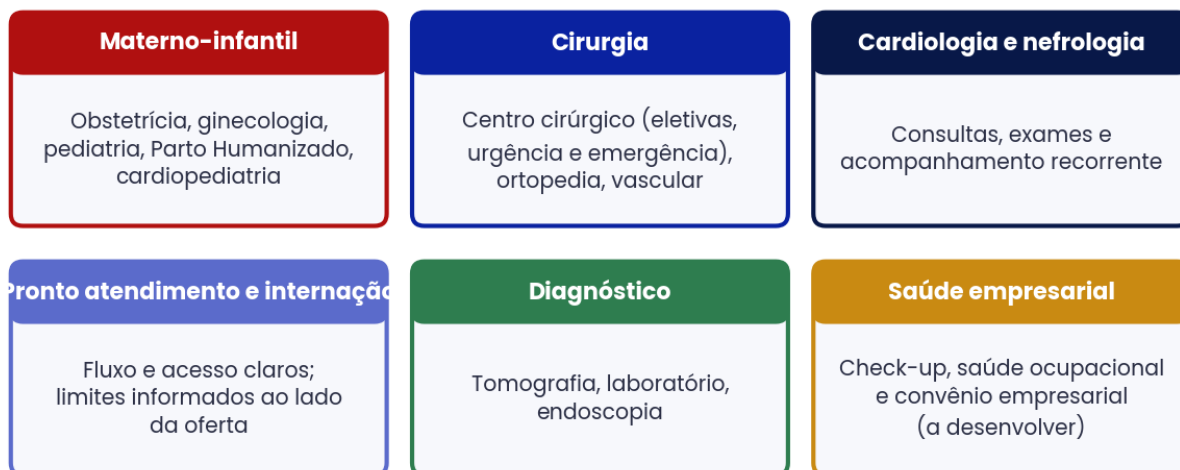
1.2 Histórico



Fonte: site institucional, 02/10/2026 [FATO]. Marcos a confirmar com a diretoria para uso oficial em peças de marca.

A história do HMSP combina duas forças: um fundador que abriu a porta em 1975 e, desde 1996, um grupo de nove médicos e um bioquímico que assumiu a gestão. Isso coloca a decisão clínica e a decisão comercial próximas, um traço de proximidade e relacionamento que o plano trata como diferencial de marca.

1.3 Perfil: portfólio, corpo clínico e marca



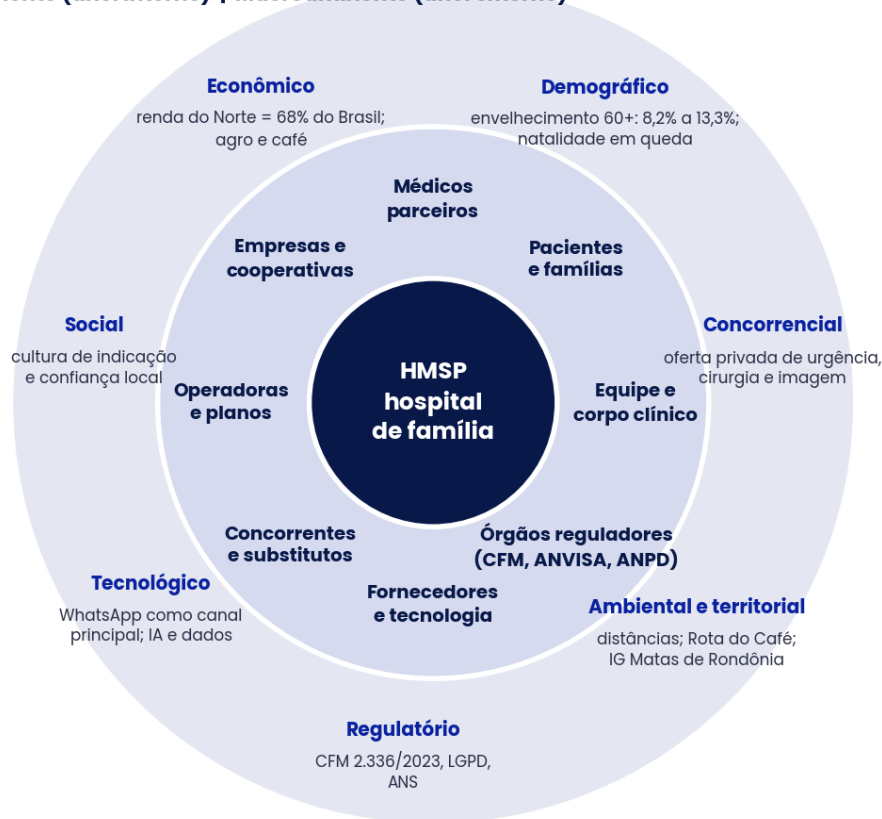
Mapa de linhas de cuidado derivado do portfólio público **[FATO]**: "Saúde empresarial" é uma linha a desenvolver (ver Capítulo II).

Elemento do perfil	Leitura
Personalidade de marca	Cuidador (principal), com traço de Sábio: zelo, proximidade, clareza técnica.
Ativos proprietários	Nome estabelecido, símbolo de coração em azul e vermelho, fundador, gestão médica desde 1996, corpo clínico identificado, Parto Humanizado.
Públicos que decidem	Famílias jovens, adultos de 40 a 69 anos, empresas e cooperativas, médicos que internam e operam.
Vantagem competitiva potencial	"Conduzido por médicos da região desde 1996": um argumento que concorrentes não replicam em uma semana.
Sensibilidade	Concentração de decisão e relacionamento em poucas pessoas: o plano cria processos e equipe para que o conhecimento seja institucional.

1.4 Mapa de ambiente

O mapa mostra, em anéis, o microambiente (quem se relaciona diretamente com o hospital) e o macroambiente (forças que o hospital não controla, mas que moldam a demanda).

Microambiente (anel interno) | Macroambiente (anel externo)



Mapa de ambiente do HMSP: elaboração própria a partir de fontes públicas **[HIPÓTESE]**.

Fator	Evidência	Implicação para o HMSP
Demográfico	Grupo 60+ de Cacoal: de 8,2% para 13,3% (2010 a 2022); 20-39 anos = 33,1%	Duas frentes de demanda: famílias jovens e adultos maduros.
Econômico	Renda per capita do Norte = 68% da nacional; cobertura de planos em Cacoal 10,4% (estoque)	Mercado privado estreito: valorizar convênios corporativos, preço claro e eficiência.
Regional	IG Matas de Rondônia e Rota do Café cobrem Cacoal e mais 14 municípios; serviços = 77,5% do valor adicionado (2013)	Economia do café como porta para o ICP-3.
Regulatório	Resolução CFM 2.336/2023; LGPD (art. 11); ANS	Comunicação e dados com governança desde o dia 1.
Tecnológico	WhatsApp como canal dominante; avanço de CRM, BI e IA	Oportunidade de integrar canais e dados em um ecossistema próprio.
Concorrencial	Oferta privada de urgência, trauma, ortopedia e imagem	Vencer onde é diferente: família, médicos da região e relacionamento.

1.5 Mapa de situação

FORÇAS (internas)

- Mais de 50 anos de presença em Cacoal
- Gestão por médicos sócios desde 1996
- 33 especialidades e corpo clínico identificado
- Maternidade, pediatria e Parto Humanizado
- Centro cirúrgico, tomografia e internação
- Símbolo e nome reconhecíveis

OPORTUNIDADES (externas)

- Mães de 25 a 39 anos concentram a demanda
- Rota do Café e IG Matas de Rondônia
- Convênios corporativos e cooperativas
- Rede de médicos da Região Café e Zona da Mata
- Referência materno-infantil para vizinhos
- Canais digitais pouco disputados na região

ESPAÇO DE EVOLUÇÃO (internos)

- Dados e medição integrados em uma base única
- Padronização de contatos e linguagem
- Ferramentas de relacionamento (CRM) e BI
- Agenda e informações por profissional
- Rotina de conteúdo e prova social
- Mapa de capacidade por linha de cuidado

ATENÇÃO (externas)

- Mercado privado alcançável estreito
- Renda e planos abaixo da média nacional
- Natalidade em queda no estado
- Concorrentes privados em urgência e cirurgia
- Regras de publicidade médica e LGPD
- Novos entrantes e centros de imagem

Mapa de situação: forças e oportunidades alavancam o crescimento; o espaço de evolução e os fatores de atenção orientam as prioridades **[HIPÓTESE]**.

Leitura: o conjunto de forças (gestão médica, corpo clínico, maternidade e marca) é superior ao que a comunicação atual projeta. O espaço de evolução está sobretudo em integração: unir dados, canais e linguagem para que a qualidade que já existe seja percebida, medida e multiplicada.

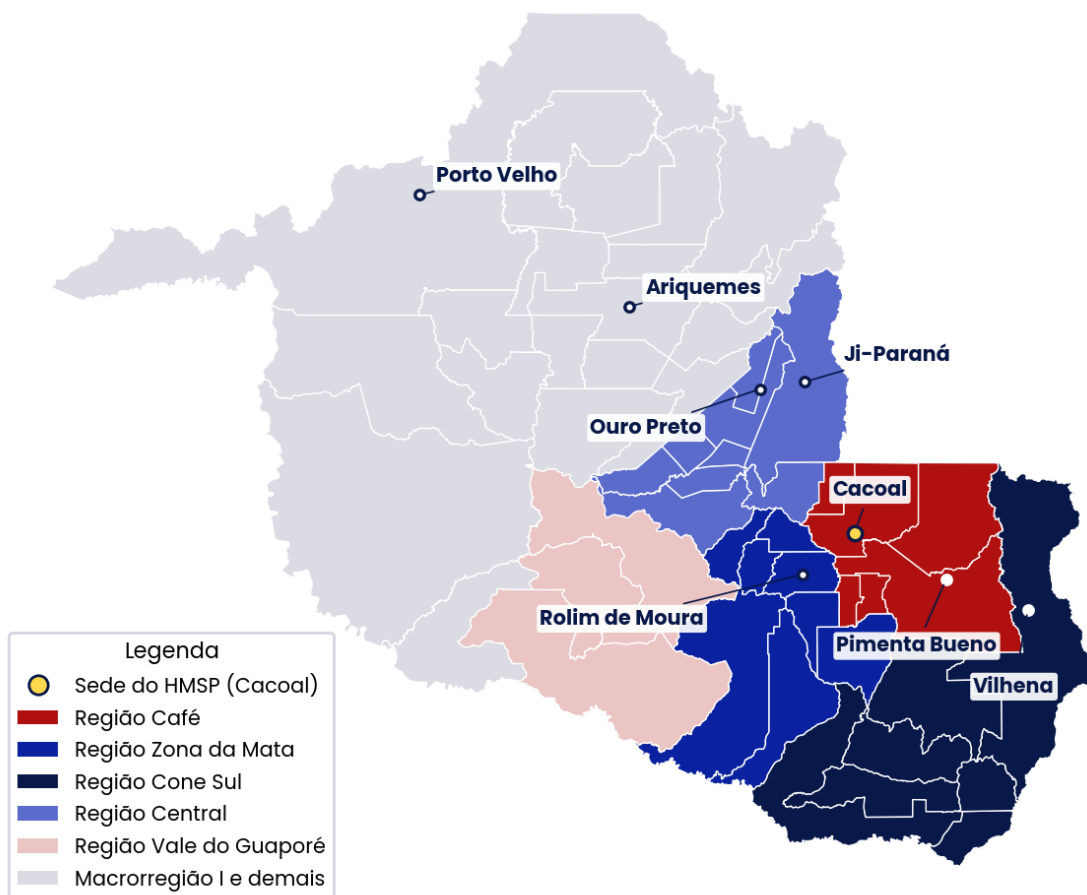
1.6 Mapa de partes interessadas

Parte interessada	O que valoriza	Como o plano a atende	Canal de relação
Pacientes e famílias	Acolhimento, clareza, proximidade	Linguagem única, jornada clara, pós-atendimento	WhatsApp, recepção, redes
Médicos parceiros	Estrutura, agenda, retorno de informação	Programa Médico Parceiro, página "Para médicos"	Reuniões, portal, WhatsApp médico
Empresas e cooperativas	Previsibilidade de custo, saúde ocupacional	Pacote empresarial e proposta única	Visita, reunião, proposta
Operadoras e planos	Rede credenciada e informação atualizada	Lista textual de convênios, mensal	Gestão de contratos
Equipe e corpo clínico	Reconhecimento, ferramentas, clareza	Intranet, treinamento, endomarketing	Teams, SharePoint, reuniões
Órgãos reguladores	Conformidade e segurança da informação	Fluxo de revisão CFM/LGPD	Diretor técnico, encarregado

1.7 Mapa de praça

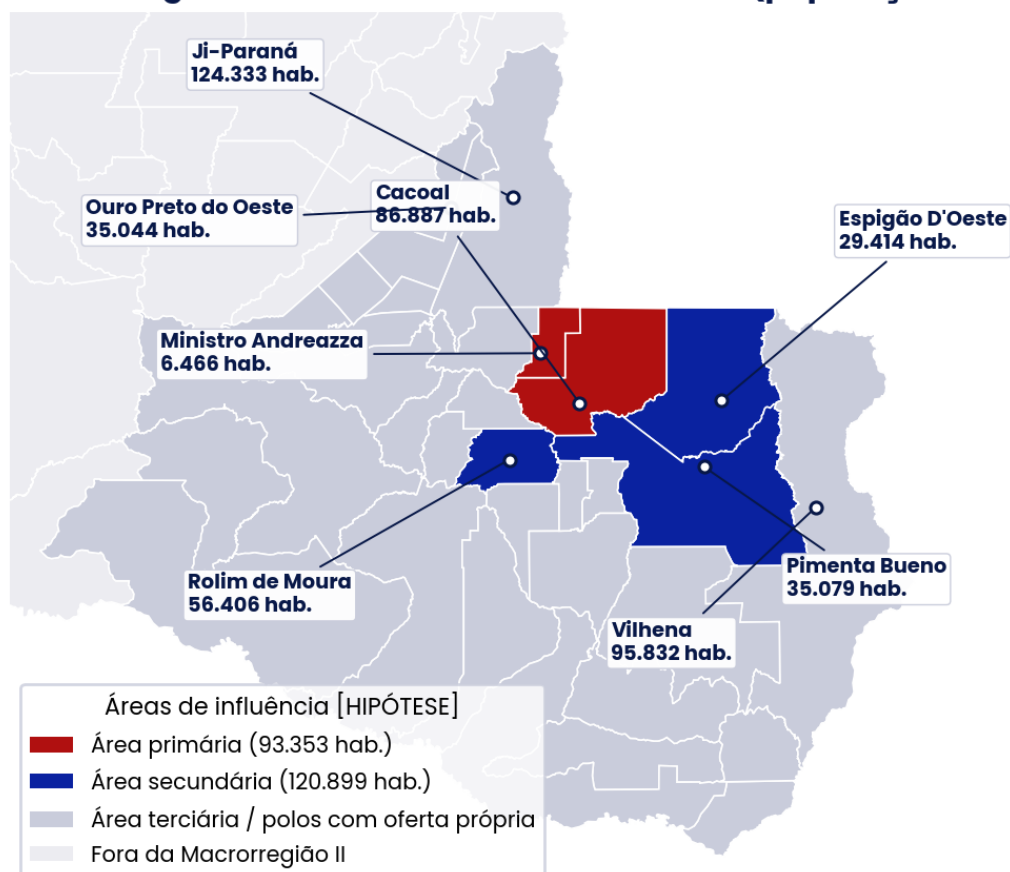
A praça é lida em três escalas: o estado de Rondônia e suas regiões de saúde, a Macrorregião de Saúde II e as áreas de influência do HMSP. As cores seguem a identidade visual: vermelho para a sede e a área primária, azul para a secundária e tons neutros para polos com oferta própria.

Rondônia: 52 municípios e as regiões de saúde da Macrorregião II



Rondônia por regiões de saúde. Agrupamento por região conforme o Plano Regional e o RDQA da SESAU/RO [DADO]; pequenas diferenças de enquadramento devem ser conferidas com a SESAU.

Macrorregião II: áreas de influência do HMSP (população, Censo 2022)



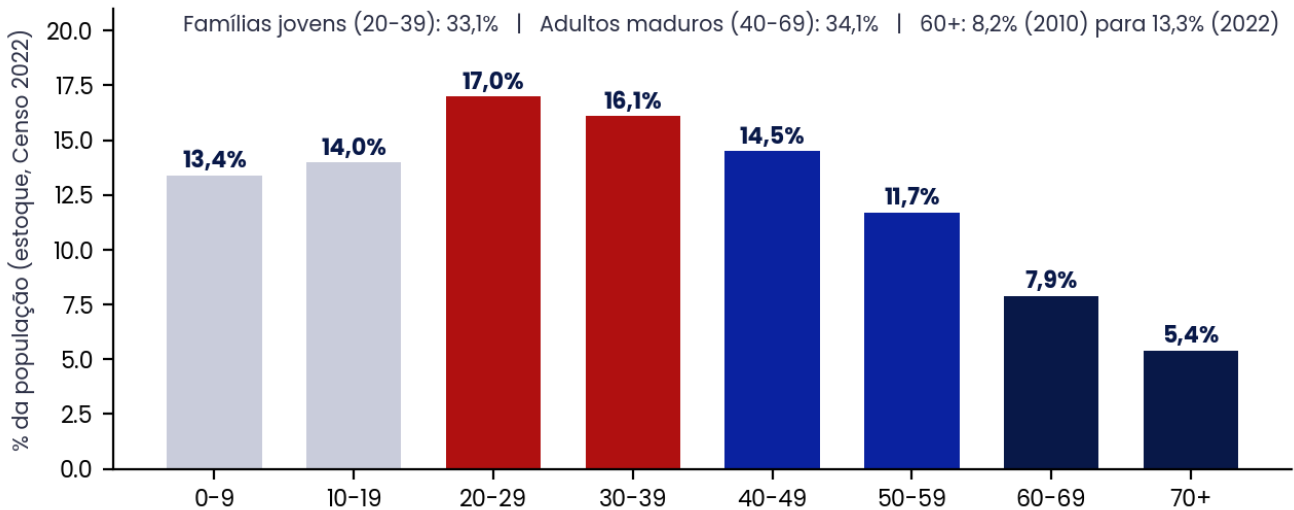
Macrorregião II e áreas de influência do HMSP [HIPÓTESE]. População: IBGE, Censo 2022 (estoque) [DADO].

Região de saúde (Macro II)	Municípios	Nº
Café	Cacoal (sede do HMSP), Espigão d'Oeste, Ministro Andreazza, Pimenta Bueno, Primavera de Rondônia, São Felipe d'Oeste	6
Zona da Mata	Rolim de Moura, Alta Floresta d'Oeste, Alto Alegre dos Parecis, Castanheiras, Nova Brasilândia d'Oeste, Novo Horizonte do Oeste, Santa Luzia d'Oeste, Parecis	8
Cone Sul	Vilhena, Colorado do Oeste, Cerejeiras, Cabixi, Corumbiara, Pimenteiras do Oeste, Chupinguaia	7
Central (parte)	Ji-Paraná, Ouro Preto do Oeste, Presidente Médici, Urupá, Nova União, Teixeiraópolis, Vale do Paraíso, Mirante da Serra, Alvorada d'Oeste e demais	10
Vale do Guaporé	São Miguel do Guaporé, Seringueiras, São Francisco do Guaporé	3
Total da Macrorregião II	735.852 habitantes (estoque) (IBGE 2022, SESAU/RO)	34

Área de influência [HIPÓTESE]	Municípios	População (estoque)	% Macro II
Primária	Cacoal e Ministro Andreazza	93.353	12,7%
Secundária	Rolim de Moura, Pimenta Bueno e Espigão d'Oeste	120.899	16,4%
Terciária	Restante da Macro II (inclui Ji-Paraná e Vilhena, com polos próprios)	521.600	70,9%
Alcance ativo	Primária + secundária: base de SAM e SOM	214.252	29,1%

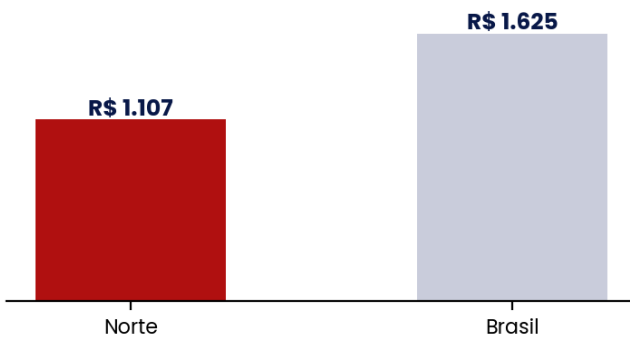
Demografia, renda e cobertura de planos de Cacoal

Cacoal: composição etária da população

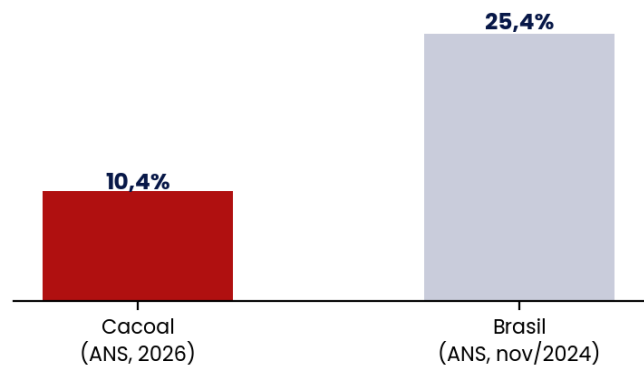


Fonte: IBGE, Censo 2022 **[DADO]**. Percentuais sobre a população total (**estoque**).

Renda domiciliar per capita, 2022 (R\$ por mês)



Cobertura de planos de saúde (% da população)



Fonte: IBGE (renda, 2022) e ANS (cobertura) **[DADO]**. Cobertura: ≈10.155 beneficiários em Cacoal (**estoque**).

Indicador de Cacoal	Valor	Fonte e rótulo
População (2022) (estoque)	86.887 hab.; 22,91 hab/km²	IBGE Censo 2022 [DADO]
Mortalidade infantil (2023, por ano)	8,94 por mil nascidos vivos	IBGE, com base em DATASUS [DADO]
PIB per capita (2023, por ano)	R\$ 44.292,79	IBGE Cidades [DADO]
Região Geográfica Imediata	14 municípios; 293.682 hab. (estoque)	IBGE [DADO] ; recorte geográfico, não fluxo de pacientes
Café	IG “Matas de Rondônia” cobre Cacoal e mais 14 municípios; Lei 5.958/2025 define a Rota do Café	INPI; Governo de RO [FATO]
Valor adicionado (2013)	Serviços 77,5%; agropecuária 11,1%; indústria 11,4%	IBGE via IFRO [DADO, dado antigo]

LEITURA DA PRAÇA

Cacoal é a terceira maior cidade da Macrorregião II, polo da Região Café e referência materno-infantil para vizinhos. A população envelhece e a renda é sensível, o que estreita o mercado privado alcançável: o crescimento virá de convênios corporativos, alcance regional e eficiência, mais do que de volume genérico.

1.8 O que ainda será calibrado (e como)

- Nota e comentários no Maps, Instagram e Facebook **[SEM ACESSO]**: coletar 100 avaliações e 30 posts na primeira rodada.
- Faturamento, ocupação, margem por linha e mix de pagadores: planilha interna, em ciclos de 30 dias, nos próximos 7 dias.

- Capacidade real (leitos, salas, partos **/mês**): CNES e relatório da diretoria clínica.
- Percepção e tempos de atendimento: ouvidoria interna e pesquisa primária (Anexo A).

LIVRO 1 | MARKETING | CAPÍTULO 2

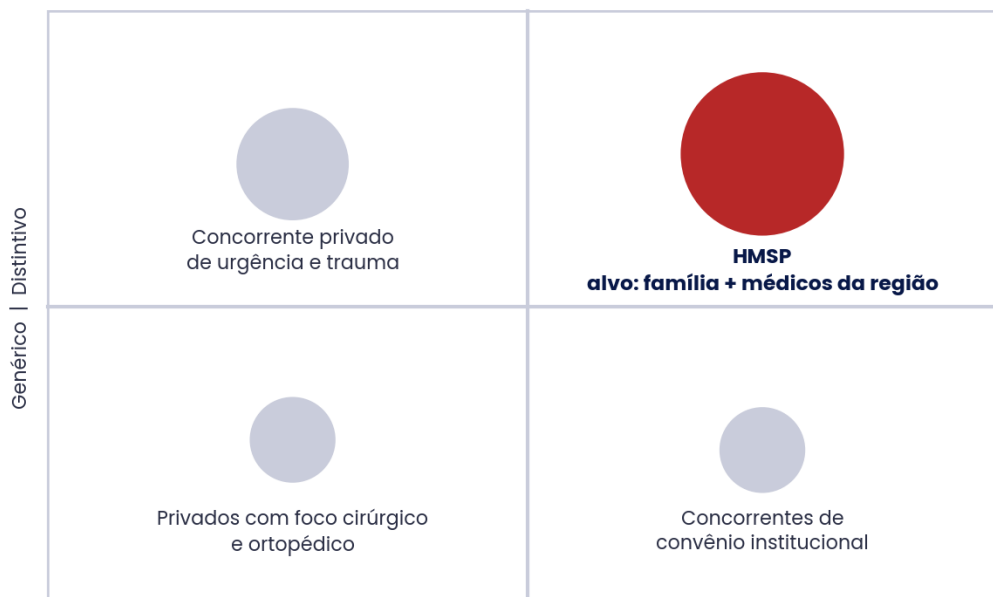
Concorrência privada na praça

TESE

O HMSP compete na praça com prestadores privados, por jornada e por serviço. O concorrente mais visível em urgência e maternidade é o Hospital dos Acidentados e Maternidade São Lucas. O São Paulo vence onde é diferente: gestão médica, corpo clínico clínico-cirúrgico amplo e proximidade com famílias e empresas.

Instituição	O que se sabe	Hipótese de posicionamento	Risco ao HMSP
Hospital dos Acidentados e Maternidade São Lucas	Privado; ativo desde 1990; CNAE principal em urgência, com diálise, laboratório, remoção e UTI móvel [DADO: Receita Federal] . Listado na Angels Initiative (AVC) [FATO] .	Urgência, trauma e maternidade [HIPÓTESE]	Alto: urgência e maternidade
Hospital Geral e Ortopédico (HGO)	Privado [DADO: Sebrae/RO] . O nome indica ortopedia.	Ortopedia e cirurgia [HIPÓTESE]	Médio: cirurgia eletiva
Hospital Samar / Samaritano	Rede privada com urgência, cirurgia, internação e diagnóstico; denominação a confirmar [SEM ACESSO] .	A confirmar	Médio
Hospital do Servidor	Privado [DADO: Sebrae/RO] .	Convênios institucionais [HIPÓTESE]	Médio: convênios corporativos
Hospital São Daniel Comboni	Privado, com nicho de prevenção oncológica [DADO] .	Nicho especializado	Baixo a médio
CEDIM e centros de imagem	Substituto de diagnóstico eletivo.	Imagem e apoio diagnóstico	Médio: tomografia e exames

Espaço de posicionamento (mapa qualitativo) [HIPÓTESE]



Foco em procedimento e urgência (esquerda) | Foco em família e relacionamento (direita)

Mapa qualitativo de posicionamento **[HIPÓTESE]**. Preço, ocupação, produção e capacidade relativa dos concorrentes: ND (não disponíveis).

COMO GANHAR SEM COPIAR

O HMSP é o único dessa lista cuja história pública começa com um médico fundador e passa a um grupo de médicos sócios. Isso sustenta um argumento que o concorrente não replica em uma semana: “conduzido por médicos da região desde 1996”. Teste: citar a frase em 20 entrevistas e medir se aumenta a confiança frente às alternativas.

Diferenciais genéricos (“humanizado”, “excelência”, “24h”, “estrutura”) são códigos da categoria, não ativos proprietários.

LIVRO 1 | MARKETING | CAPÍTULO 3

Mercado dimensionado: TAM, SAM e SOM

TESE

Com dados públicos, o dimensionamento é uma triangulação em duas abordagens e três faixas. O resultado mais importante é uma forma: o mercado privado acessível ao HMSP tem poucas dezenas de milhares de pessoas (**estoque**) e poucas dezenas de partos por mês. Toda estimativa tem baixa confiança até receber faturamento e mix de pagadores. Como o hospital planeja em ciclos de 30 dias, cada grandeza anual vem com o equivalente mensal.

Funil de mercado, cenário base [ESTIMATIVA-MÉTODO]



TAM | população da Macro II (estoque)
735.852



SAM-1 | com acesso privado (12/17/22%)
125.100 (88.300 a 161.900)



SAM-2 | no alcance ativo (29,1%)
36.400 (25.700 a 47.100)

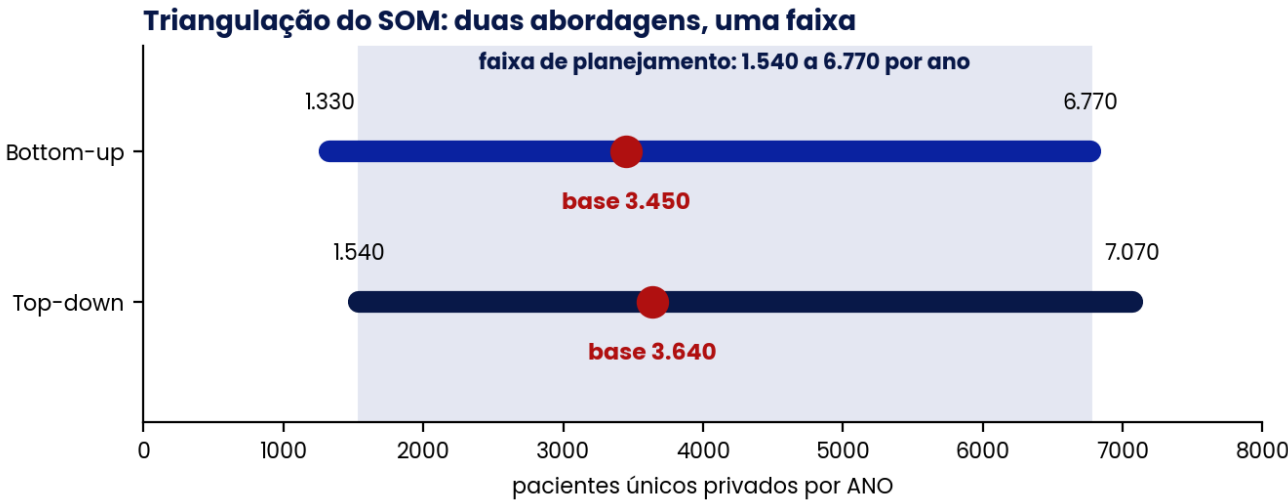


SOM | pacientes únicos privados por ANO
3.640 (1.540 a 7.070)

Cenário base [ESTIMATIVA-MÉTODO]. TAM e SAM são populações (**estoque**); SOM é fluxo de pacientes únicos por ano.

Camada (top-down)	Fórmula	Conserv.	Base	Otimista
TAM (estoque)	População da Macro II (IBGE 2022)	735.852	735.852	735.852
Acesso privado (estoque) [HIPÓTESE]	Plano 8, 11, 14% + particular 4, 6, 8%	12%	17%	22%
SAM-1 (estoque)	TAM x acesso	88.300	125.100	161.900
SAM-2 (estoque)	SAM-1 x 29,1% (alcance ativo)	25.700	36.400	47.100
SOM /ano (captura 6, 10, 15%)	SAM-2 x captura, pacientes únicos	1.540	3.640	7.070
SOM /mês (equivalente)	SOM anual dividido por 12	128	303	589

Camada (bottom-up)	Fórmula	Conserv.	Base	Otimista
Primária captada /ano	Pop. primária x acesso x captura 8, 14, 20%	900	2.220	4.110
Secundária captada /ano	Pop. secundária x acesso x captura 3, 6, 10%	440	1.230	2.660
SOM bottom-up /ano	Soma (pacientes únicos)	1.330	3.450	6.770
SOM bottom-up /mês (equivalente)	Soma anual dividida por 12	111	288	564



A faixa top-down (1.540 a 7.070 por ano) e a bottom-up (1.330 a 6.770 por ano) se sobrepõem entre 1.540 e 6.770 por ano (128 a 564 por mês), adotada como SOM de planejamento com confiança baixa.

Por linha de serviço: anual e mensal lado a lado

Linha	Premissas	TAM Macro II	SAM privado	SOM HMSP
Partos /ano	Pop. x natalidade 14,0, 15,0, 15,6 por mil; participação privada 15, 20, 25%; captura 15, 25, 35%	10.300 / 11.040 / 11.480	450 / 640 / 840	67 / 161 / 292 (top-down); 29 / 70 / 127 (bottom-up)
Partos /mês	Anual dividido por 12	858 / 920 / 957	38 / 53 / 70	6 / 13 / 24 (top-down); 2 / 6 / 11 (bottom-up)
Internações, exceto partos /ano	Taxa 3,5, 4,5, 5,5% da população [BENCHMARK a calibrar]; SOM 8, 12, 18% do SAM	25.800 / 33.100 / 40.500	900 / 1.640 / 2.590	72 / 197 / 467
Internações, exceto partos /mês	Anual dividido por 12	2.150 / 2.758 / 3.375	75 / 137 / 216	6 / 16 / 39
Urgência, diagnóstico e ambulatório	Sem taxa pública confiável de uso privado nesta rodada	[SEM ACESSO]	[SEM ACESSO]	Dimensionar com agenda e PA dos últimos 12 meses

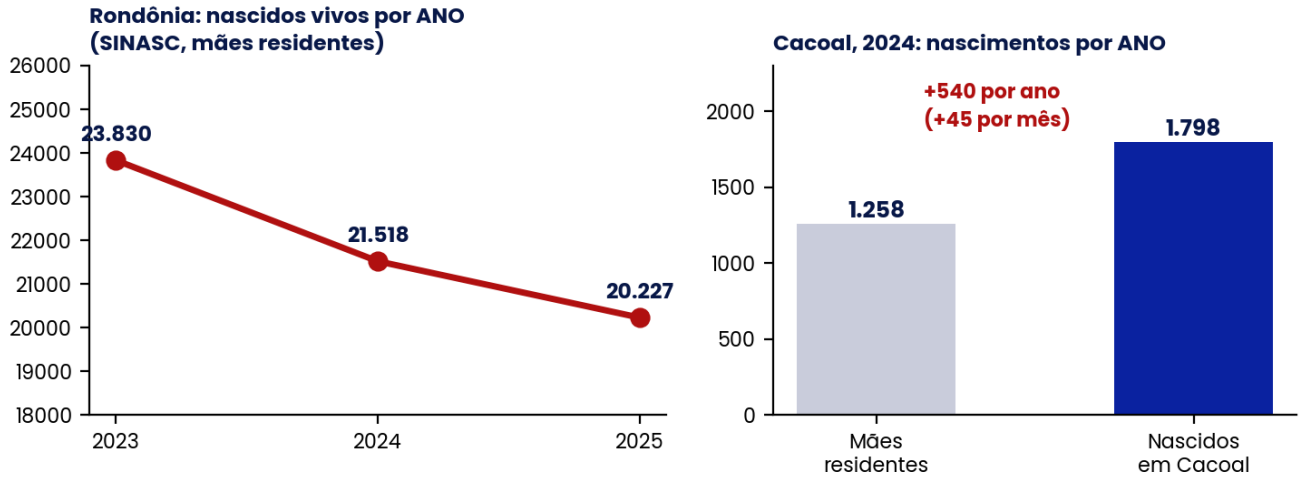
LEITURA DE DECISÃO E LIMITES

Mesmo na faixa otimista, o SOM privado de internações é de poucas dezenas por mês. A diretoria precisa responder primeiro: qual a participação de contratos e de convênios institucionais na receita (por ciclo de 30 dias)? Sem essa resposta, qualquer meta de volume é arriscada. Premissas de acesso privado, captura e taxa de internação são [HIPÓTESE] ou [BENCHMARK]. Cobertura de planos: 25,37% no Brasil (nov/2024) e cerca de 10,4% em Cacoal, com 10.155 beneficiários (estoque) [DADO: ANS].

Natalidade na Macrorregião II

TESE

Rondônia registrou 24.738 nascidos vivos em 2022 **/ano**, taxa bruta de 15,6 por mil, acima da brasileira **[DADO: IBGE, Registro Civil; cálculo próprio]**. A série do SINASC mostra queda contínua: 23.830 (2023), 21.518 (2024) e 20.227 (2025) por ano, ou cerca de 1.986, 1.793 e 1.686 por mês. Cacoal funciona como polo materno-infantil: em 2024 nasceram 1.798 bebês no município (150**/mês**) contra 1.258 filhos de mães residentes (105**/mês**). O volume total encolhe: crescer exige participação, não mercado.



Fonte: SINASC/DATASUS **[DADO]**. Valores anuais; equivalentes mensais no texto.

Indicador	Conserv.	Base	Otimista	Método e rótulo
Taxa bruta (por mil habitantes, ano)	14,0	15,0	15,6	RO 2022 = 24.738 / 1.581.196 [ESTIMATIVA-MÉTODO]
Nascimentos /ano , Macro II	10.300	11.040	11.480	735.852 x taxa
Nascimentos /mês , Macro II	858	920	957	Anual dividido por 12
Nascimentos /ano , Cacoal (residentes)	1.220	1.300	1.360	86.887 x taxa; partos ocorridos são maiores pela atração regional
Nascimentos /mês , Cacoal (residentes)	102	108	113	Anual dividido por 12
Partos privados no alcance ativo /ano	450	640	840	Nascimentos x 15, 20, 25% x 29,1%
Partos privados no alcance ativo /mês	38	53	70	Anual dividido por 12
Partos HMSP (SOM) /ano	67	161	292	Captura 15, 25, 35%; confiança baixa
Partos HMSP (SOM) /mês	6	13	24	Anual dividido por 12

No Brasil em 2023, mulheres de 30 anos ou mais responderam por 39% dos nascimentos, as de 25 a 29 por 25,5% e as adolescentes por 11,8% **[DADO: IBGE]**. Em Cacoal, cerca de 14.400 mulheres de 20 a 39 anos **(estoque)** **[HIPÓTESE: metade de 28.762]** somam 1.220 a 1.360 nascimentos **/ano**: de 8,5 a 9,4 partos por 100 mulheres nessa idade, por ano.

TESTE QUE DERRUBA A HIPÓTESE

Se, nos primeiros 100 contatos de maternidade, mais de 40% das gestantes tiverem menos de 25 anos ou não tiverem fonte pagadora privada, o ICP-1 deve ser recalibrado e a oferta redesenhada. Fonte de calibração: SINASC por município de residência e de ocorrência.

LIVRO 1 | MARKETING | CAPÍTULOS 5 E 6

ICP, consumidor e jornada

TESE

O hospital atende quatro públicos que decidem de formas diferentes: a família do primeiro filho, o adulto maduro com cuidado recorrente ou cirurgia eletiva, a empresa ou cooperativa e o médico que interna. O ICP prioritário é a família jovem de Cacoal e da Região Café com plano ou renda para particular, porque casa três coisas verificadas: especialidades listadas, estrutura etária e natalidade.

	ICP-1 Família do primeiro filho (prioritário)	ICP-2 Adulto 40 a 69 anos, recorrente e cirúrgico
Quem é	Mulher de 25 a 39 anos e parceiro, em Cacoal, Min. Andreazza e Região Café; plano ou particular; crianças 0 a 12.	Homem ou mulher de 40 a 75 anos, com plano ou particular, condição crônica ou cirurgia indicada; decisão com familiar cuidador.
Evidências	Obstetrícia, pediatria e Parto Humanizado no site; 20-39 anos = 33,1% da população; 15,6 nascimentos por mil.	Nefrologia, cardiologia e vascular no corpo clínico; 40-69 = 34,1%; 60+ de 8,2% para 13,3%; tomografia em destaque.
Job-to-be-done	Parto seguro e perto de casa; sentir-se acolhida; contar à família que escolheu bem.	Resolver sem viajar a Porto Velho ou Ji-Paraná; ser tratado por médico que a família conhece.
Barreiras	Preço, cobertura por procedimento, distância e percepção de capacidade da maternidade.	Autorização do plano, tempo de espera, checklist administrativo.
Canal e mensagem	Instagram, WhatsApp, indicação do obstetra, curso de gestantes. "Conheça a maternidade antes do parto."	Indicação médica, Google, WhatsApp. "Cuidado contínuo perto de casa, com os médicos que você conhece."
Hipótese a validar	Mais de 60% chegam por indicação do obstetra (100 conversas).	O especialista é o principal gatilho de escolha (30 entrevistas).

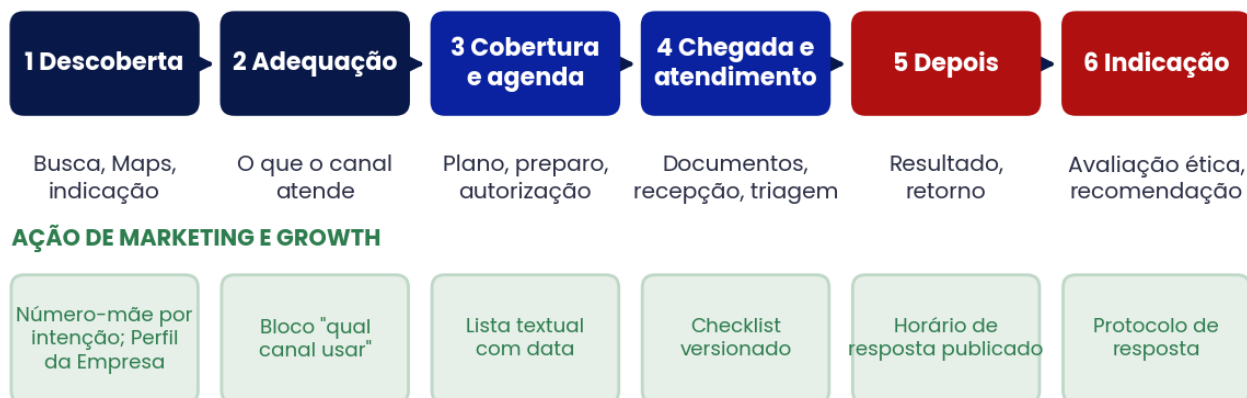
	ICP-3 Empresa ou cooperativa (B2B)	ICP-4 Médico parceiro (B2B2C)
Quem é	Cooperativas e produtores do café, comércio e serviços; decisor: sócio ou RH.	Médico clínico ou cirurgião da Região Café e Zona da Mata que interna ou opera no hospital.
Evidências	IG Matas de Rondônia e Rota do Café; serviços = 77,5% do valor adicionado.	Gestão por nove médicos desde 1996; CRM/RQE visíveis; centro cirúrgico.
Oferta	Check-up, saúde ocupacional e convênio empresarial com proposta única.	Fluxo de encaminhamento, agenda do centro cirúrgico e retorno de informação.
Hipótese a validar	Cooperativas valorizam pacote sazonal na colheita (5 reuniões).	Mais de 30% não sabem a capacidade do centro cirúrgico (10 entrevistas).

Personas de pesquisa (hipóteses, sem presumir idade, renda ou diagnóstico): pessoa de apoio à internação; responsável por criança; pessoa em demanda eletiva com cobertura a confirmar; pessoa que precisa distinguir serviço privado de deslocamento e transporte.

FORA DO ICP

Demanda de urgência regulada e demanda sem fonte pagadora definida não são alvo de mídia. O hospital apenas garante informação clara de acesso.

Jornada do paciente e momentos da verdade



Jornada em seis etapas e a ação de marketing e growth correspondente.

A jornada em saúde é decidida em dois momentos: o primeiro contato (a resposta chega em minutos e resolve?) e a primeira recepção (o prometido é o que acontece?). A prioridade é desenhar e medir esses dois momentos ao ampliar o alcance.

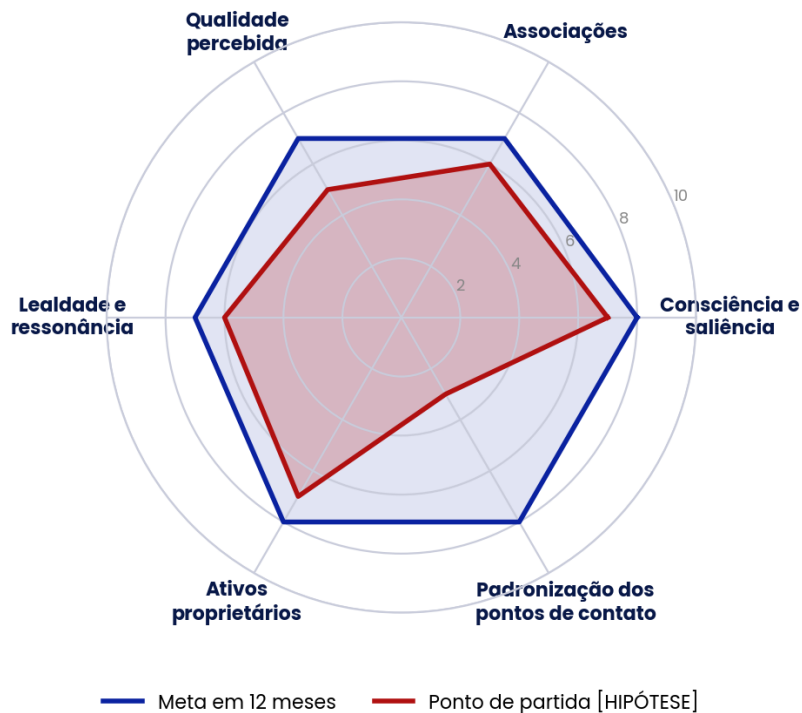
Momento	Ponto de atenção	Decisão e métrica
Antes: descoberta e dúvida	Informação de convênios e canais por intenção	Páginas de serviço e convênios em texto. Métrica: cliques em WhatsApp por serviço /mês
Durante: chegada, espera e atendimento	Fluxo e sinalização de espera	Tempo até o 1º atendimento (amostra, minutos)
Depois: resultado, cobrança e retorno	Clareza de cobrança e retorno agendado	NPS por WhatsApp (opt-in) e lembrete de retorno. Métrica: taxa de retorno em 90 dias
Indicação	Pedido ético e sistemático de avaliação	Avaliações novas /mês e % respondidas

LIVRO 2 | BRANDING | CAPÍTULOS 7 E 8

Brand equity, identidade e posicionamento

TESE

A marca do HMSP tem ativos raros (nome estabelecido, símbolo de coração em azul e vermelho, fundador, gestão médica, corpo clínico identificado). O scorecard usa proxies públicos e é **[HIPÓTESE]** até a coleta de avaliações e a pesquisa primária. A recomendação é fortalecer a distinção (médicos da região, família) e padronizar a expressão da marca em todos os pontos de contato.



Scorecard de marca (Aaker e Keller): índice composto de partida 5,7/10 **[HIPÓTESE]**; meta de 12 meses 7,5. Repetir em 90 dias com Maps, Instagram e 15 a 25 entrevistas. Não criar NPS nem equity score a partir de reviews.

Dimensão	Proxy e evidência	Nota	Confiança
Consciência e saliência	Mais de 50 anos; presença em Maps; buscas de marca a medir	7	Baixa
Associações	Positivas: zelo, família. A desenvolver: especialidade âncora, rapidez, transparência de plano	6	Baixa
Qualidade percebida	Maps 3,9/5 (137 avaliações); Reclame Aqui não acessado	5	Baixa
Lealdade e ressonância	Gerações de famílias (hipótese); afeto nas redes	6	Baixa
Ativos proprietários	Nome, coração, fundador, 1996, corpo clínico com CRM/RQE, Parto Humanizado	7	Média
Padronização dos pontos de contato	Telefone, CTA, horários e narrativa histórica em formato único: a dimensão de maior alavancagem e menor custo	3	Média

Identidade visual

Vermelho Zelo #B01010	Azul Marinho #081848	Azul São Paulo #0A22A0	Papel #F1F1EF
--------------------------	-------------------------	---------------------------	------------------

Vermelho: coração, destaques e CTAs principais. Azul marinho: títulos, fundos institucionais e tabelas. Azul São Paulo: links, botões secundários e gráficos. Tipografia: sans geométrica arredondada em negrito; Poppins é a fonte de trabalho por semelhança, e a família do logotipo deve ser confirmada com o autor da marca. Preservar logotipo e

paleta oficiais até receber os arquivos mestres.

Posicionamento em camadas

Alternativa	Atributo e segmento	Prós	Trade-offs
A. Maternidade e família	Parto humanizado, pediatria e ginecologia; ICP-1	Emoção forte; ativo existente; lealdade familiar	Capacidade e UTI neonatal precisam estar claras
B. Cirurgia segura com os médicos da região	Centro cirúrgico e especialistas; ICP-2 e ICP-4	Volume e margem; explora a gestão médica	Depende de médicos parceiros; ortopedia é disputada
C. Pronto atendimento claro	Informação de fluxo e acesso	Alta demanda e visibilidade	Promessa 24H exige prova; urgência regulada fora do alvo

FRASE CENTRAL E PLATAFORMA

Combinar em camadas: maternidade e família como âncora emocional (o que a marca é), rede de médicos e cirurgias eletivas como motor de volume (como cresce) e pronto atendimento claro como porta de entrada. Frase central: "O hospital da família de Cacoal, conduzido por médicos da região desde 1996".

Opção a testar internamente: "Hospital São Paulo. Próximo passo, com clareza." (princípio: cada peça diz o serviço, o canal, o limite e o próximo passo; testar compreensão, anterioridade e revisão jurídica antes de publicar).

Elemento	Proposta
Propósito	Cuidar de cada família de Cacoal e da região, do primeiro choro ao cuidado de toda a vida.
Visão	Ser o hospital em que as famílias e os médicos da região escolhem confiar, por gestão próxima, clareza e resultado medido.
Missão	Oferecer assistência segura e humana, com corpo clínico identificado e processos claros do primeiro contato ao pós-atendimento.
Valores praticados	Zelo, proximidade, clareza, responsabilidade técnica, respeito ao paciente.
Promessa	Você sabe com quem, onde e como será atendido, e não está sozinho.
Pilares	1. Família e maternidade. 2. Médicos da região. 3. Clareza no atendimento.
Assinaturas possíveis	1) "Há mais de 50 anos, médicos cuidando de famílias de Cacoal." (recomendada, após validar a data) 2) "Você não está sozinho." 3) "Cuidado de família, estrutura de hospital." 4) "Do primeiro choro ao cuidado de toda a vida."

LIVRO 2 | BRANDING | CAPÍTULO 9

Linguagem de comunicação e guia de voz

TESE

Uma marca de família se reconhece pelo jeito de falar. Este capítulo fixa a linguagem do HMSP em todos os pontos de contato (site, WhatsApp, telefone, recepção, redes, vídeo, material impresso e relação com médicos), para que paciente, médico e empresa ouçam a mesma voz.

Princípio de voz	Como soa	Exemplo
Acolhedora	Fala com a pessoa, não sobre o procedimento	"Estamos aqui para cuidar de vocês nessa etapa."
Clara	Uma ideia por frase; serviço, canal, limite e próximo passo	"Agende pelo WhatsApp. Resposta em até 5 minutos em horário comercial."
Próxima e regional	Conhece Cacoal e a Região Café	"Perto de casa, com médicos que a região conhece."
Responsável	Sem superlativos nem promessa de resultado	"Informação sujeita a confirmação com o convênio."
Profissional	Técnica quando necessário, sempre traduzida	"Cesariana, quando indicada pelo obstetra, com equipe preparada."

Dizer	Evitar	Por quê
"Pronto atendimento todos os dias, das ... às ... Veja o fluxo e o endereço."	"O melhor pronto atendimento da região."	Superlativo sem prova (CFM, CDC)
"Conheça nossa maternidade em uma visita agendada."	"Parto sem dor garantido."	Promessa de resultado
"Plano aceito: confirme pelo WhatsApp. Atualizado em 01/10."	"Aceitamos todos os convênios."	Informação não verificável
"Dra. Fulana, CRM-RO ..., RQE ..., atende às terças."	"Médico de excelência"	Autopromoção
"Atendimento por mensagem, resposta em até 5 minutos em horário comercial."	"Respondemos na hora."	Compromisso vago

Canal	Tom e formato	Regra de ouro
WhatsApp	Saudação com menu por intenção; frases curtas; nome do atendente	Sempre oferecer humano; nunca dado clínico por texto
Telefone e recepção	Script padrão de abertura e encerramento; registro do motivo	Um número-mãe por intenção
Instagram e vídeo	Rostos da equipe (com autorização), histórias de cuidado sem expor casos	Sem imagem de paciente sem TCLE
Site e Google	Páginas de serviço com limites, horários e convênios em texto	Data de atualização visível
Médicos e empresas	Objetivo, dados e retorno de informação	Proposta única e escrita
Impressos e sinalização	Ícones, cores da marca, textos de até duas linhas	Mesma hierarquia visual em todo o prédio

Roadmap de solidificação da marca

Horizonte	Entregas de marca e linguagem	Responsável
Dia 90	Auditoria de pontos de contato; brand book v1 (logo, cores, tipografia, voz, modelos); glossário de linguagem; templates de redes, WhatsApp e impressos; narrativa oficial de marcos validada	Coordenação e design
Dia 120	Aplicação em site, Perfil da Empresa, WhatsApp, assinaturas de e-mail e uniformes; treinamento de voz para recepção e enfermagem	Design, social media e RH

Horizonte	Entregas de marca e linguagem	Responsável
Dia 240	Sinalização interna e externa; enxoval da maternidade com a marca; série de vídeos “médicos da região”; pesquisa de marca (rodada 2)	Design e audiovisual
Dia 365	Brand book v2; scorecard de marca 7,5; manual do Programa Médico Parceiro; identidade da marca empregadora	Coordenação

COMPLIANCE DE COMUNICAÇÃO

Revisar a Resolução CFM 2.336/2023 e o Manual de Publicidade Médica antes de publicar: identificação do estabelecimento e do diretor técnico, regras de imagem, depoimentos e claims. Sem imagem de paciente, prontuário, pulseira ou tela como recurso de rotina. A LGPD protege dado de saúde como sensível. Responder avaliações sem confirmar vínculo assistencial e sem expor caso. Este material não substitui a validação do Diretor Técnico, do jurídico e do Encarregado.

LIVRO 3 | GROWTH | CAPÍTULO 10

North Star, funil e atribuição

TESE

Primeiro mede-se, depois se acelera. A North Star é “jornadas qualificadas concluídas por mês” (contato com intenção registrada, atendimento comparecido e resultado entregue), com a TRJA como métrica administrativa mensurável sem dado clínico. Guard-rails protegem a escala.

TRJA: TAXA DE RESOLUÇÃO DE JORNADA ADMINISTRATIVA

TRJA = jornadas administrativas concluídas com confirmação verificável ÷ jornadas administrativas elegíveis iniciadas, dentro da janela aprovada (mensal, ciclo de 30 dias). Conclusão administrativa é, por exemplo, confirmação de recebimento: não é consulta, internação, autorização, resultado nem desfecho clínico.

Guard-rail	Meta inicial [RECOMENDAÇÃO]	Critério de corte
Tempo mediano da 1ª resposta	Até 5 min em horário comercial e até 15 min fora dele	Pausar mídia se acima por 7 dias
Satisfação (NPS)	Baseline em 30 dias; meta definida depois	Revisar a oferta se cair 10 pontos
Conformidade	Zero peça sem revisão CFM e LGPD	Retirar a peça no mesmo dia
Margem e capacidade	Não promover serviço sem capacidade e margem confirmadas	Interromper a campanha se a ocupação passar do limite da direção

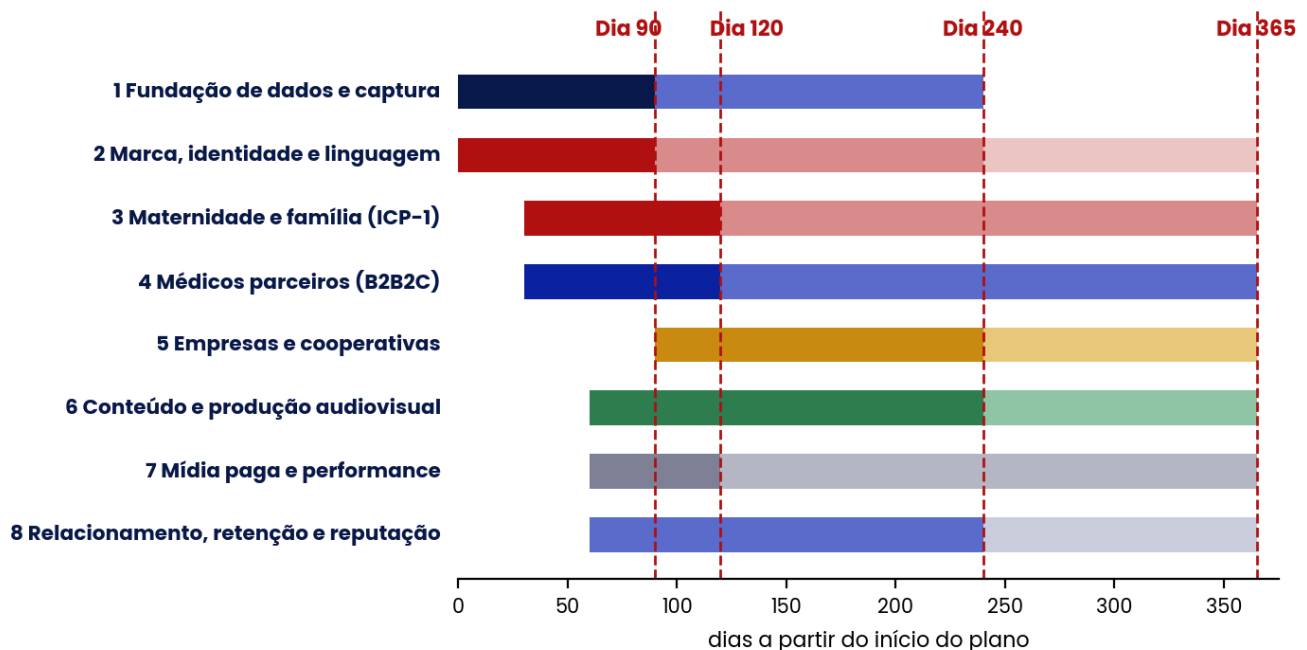
Camada de dados	Especificação	Responsável
Links	Um link de WhatsApp por serviço e origem (Site, Instagram, Maps, QR), com texto pré-preenchido e código curto (ex.: MAT-IG)	Marketing
Eventos GA4/GTM	click_whatsapp (serviço, origem), click_telefone, envio_formulario, ver_pagina_servico, ver_corpo_clinico	Marketing e programador
UTMs	utm_source, utm_medium, utm_campaign, utm_content padronizados	Marketing
Ligações	Número rastreável por canal ou pergunta “como nos conheceu?” com 6 opções	Recepção
Offline	Registro no CRM: contato, agendamento, comparecimento, convênio, valor (sem dado clínico)	Recepção e faturamento
Allowlist de eventos	Parâmetros permitidos: página-modelo, canal, finalidade, campanha. Proibidos: nome, telefone, e-mail, CPF, carteirinha, prontuário, diagnóstico, sintoma, exame, texto livre e localização individual	Encarregado LGPD

LIVRO 3 | GROWTH | CAPÍTULO 11

Plano diretor de growth: 90, 120, 240 dias e 1 ano

TESE

Crescimento exponencial, escalável e alcançável nasce de sistemas que se alimentam: cada paciente bem atendido gera indicação, cada médico parceiro gera encaminhamentos, cada empresa gera famílias. O plano diretor integra marca, linguagem, relacionamento, conteúdo, eventos, mídia e dados em oito pilares, com quatro horizontes e metas verificáveis. As projeções são **[HIPÓTESE]** a calibrar a cada ciclo de 30 dias.

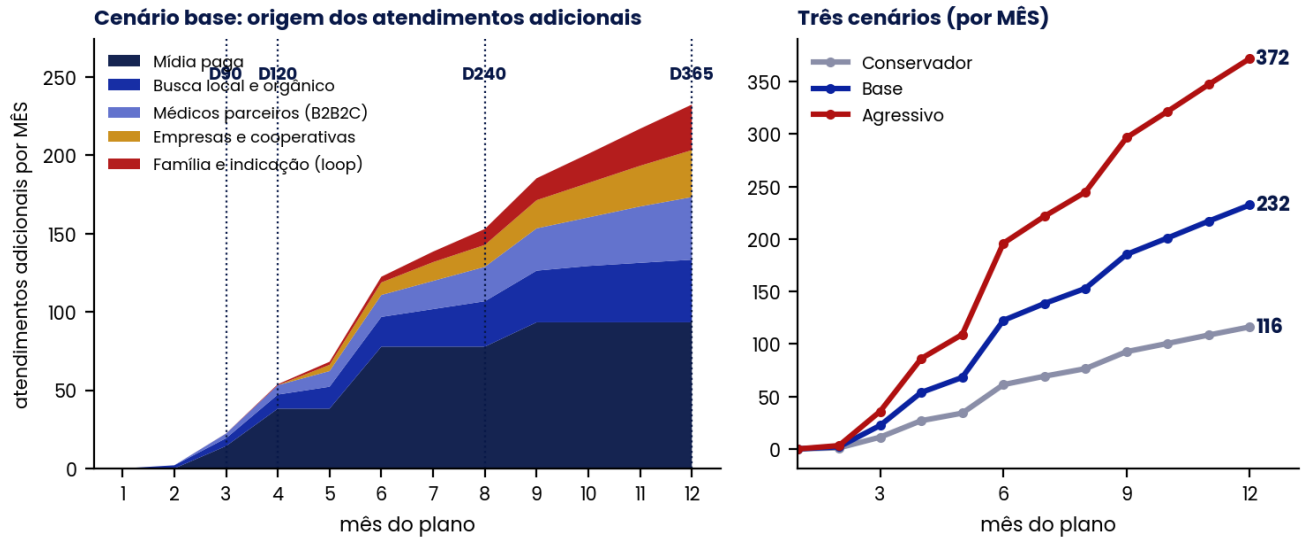


Oito pilares do plano diretor ao longo de 365 dias. Cores mais claras indicam fase de escala e manutenção.

Horizonte	Foco	Ações-chave por pilar	Meta (por mês, salvo indicação)
Dias 1 a 90 Fundação	Medir, padronizar e montar o time	Números e links por intenção; GA4/GTM; Perfil da Empresa; planilha-CRM; brand book v1 e glossário de voz; 15 entrevistas; oficinas do mapa de situação; contratação de coordenação, social media, design e filmmaker; páginas de convênios e pronto atendimento; reunião inicial com médicos; mídia só ao fim, com gates	≥90% dos contatos com origem; 1ª resposta ≤5 min; 100 gestantes com contato (acumulado); 10 médicos em reunião (acumulado)
Dias 91 a 120 Ativação	Ligar o que foi montado	CRM piloto; WhatsApp triado com IA administrativa em piloto; aplicação da marca em site e uniformes; curso de gestantes (1ª turma); visita guiada; proposta a 5 empresas/cooperativas; vídeo curto de pré-natal; mídia local de teste (R\$ 4 a 7 mil/mês)	Primeiros 38 atendimentos adicionais/mês; 3 propostas B2B; NPS baseline
Dias 121 a 240 Escala	Escalar canais com gates verdes	Programa Médico Parceiro completo; portal "Para médicos"; Google Ads local e Meta Ads (R\$ 10 mil/mês); série "médicos da região"; pacote ocupacional para a colheita; rádio/OOH regionais; eventos e palestras; lembrete 24 h e NPS; painéis Power BI; sinalização e enxoval	≈150 atendimentos adicionais/mês no mês 8; 3 turmas do curso; 5 empresas com contrato ou piloto; no-show em queda
Dias 241 a 365 Composição	Crescimento composto e previsível	Loops de família e empresas em produção; indicação estruturada; IA em produção; previsão de no-show e demanda; brand book v2; pesquisa de marca (rodada 2); planejamento do ano 2 com margem por linha	≈230 atendimentos adicionais/mês no mês 12 (base); scorecard de marca ≥7,5; retorno em 90 dias medido

Modelo de crescimento composto

A conta é explícita: atendimentos adicionais / mês = média ÷ custo por contato qualificado × conversão para comparecimento + busca local + médicos parceiros + empresas + indicação. A indicação é o termo exponencial: assumimos que 2,5% dos atendimentos adicionais acumulados geram novo atendimento a cada mês [HIPÓTESE]. Os cenários multiplicam as rampas por 0,5 (conservador), 1,0 (base) e 1,6 (agressivo).

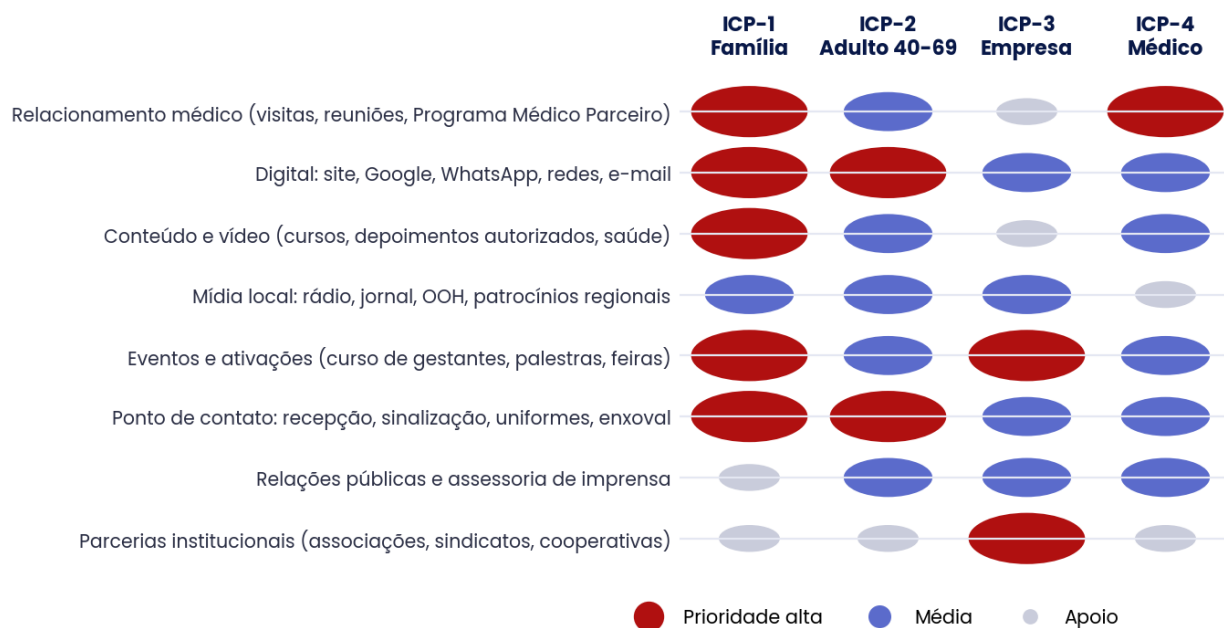


Atendimentos adicionais por mês (não são pacientes únicos). Média: R\$ 4 mil no mês 3, 7 mil nos meses 4-5, 10 mil nos meses 6-8 e 12 mil a partir do mês 9, com custo por contato de R\$ 70 a 45 e conversão de 25 a 35% [HIPÓTESE].

Marco	Conservador	Base	Agressivo
Mês 3 (dia 90): atendimentos adicionais /mês	11	22	36
Mês 4 (dia 120) /mês	27	54	86
Mês 8 (dia 240) /mês	76	153	245
Mês 12 (dia 365) /mês	116	232	372
Acumulado em 12 meses	698	1.396	2.233

Mix de comunicação integrado

O plano diretor não depende apenas de mídia digital. Cada canal tem papel por público: relacionamento médico e eventos sustentam ICP-1 e ICP-4; digital e conteúdo sustentam ICP-1 e ICP-2; parcerias e relações públicas abrem o ICP-3.



Matriz canal x público: prioridade de investimento de tempo e verba.

Frente	Ações e cadência	Dono
Relacionamento médico	Reunião trimestral; visita mensal a 3 especialidades; retorno de informação por caso; página "Para médicos"	Coordenação
Eventos e ativações	Curso de gestantes mensal; visita guiada à maternidade; palestras em associação comercial e sindicatos; presença na colheita	Coordenação e social media
Mídia local	Rádio, jornal e OOH em Cacoal e Região Café; patrocínios de eventos de saúde; Google Ads local	Coordenação
Relações públicas	Pauta mensal com imprensa local sobre serviços e datas de saúde; porta-vozes médicos autorizados	Coordenação
Conteúdo e vídeo	3 vídeos curtos/semana, 1 vídeo institucional/mês, blog mensal ligado a serviços reais	Filmmaker, editor e social media
Ponto de contato	Recepção, sinalização, uniformes, enxoval, mensagens de espera	Design e RH
Endomarketing	Boletim, campanhas internas, reconhecimento, treinamento de voz	Coordenação e RH

LOOP DE BUSCA LOCAL



LOOP B2B2C



LOOP DE FAMÍLIA

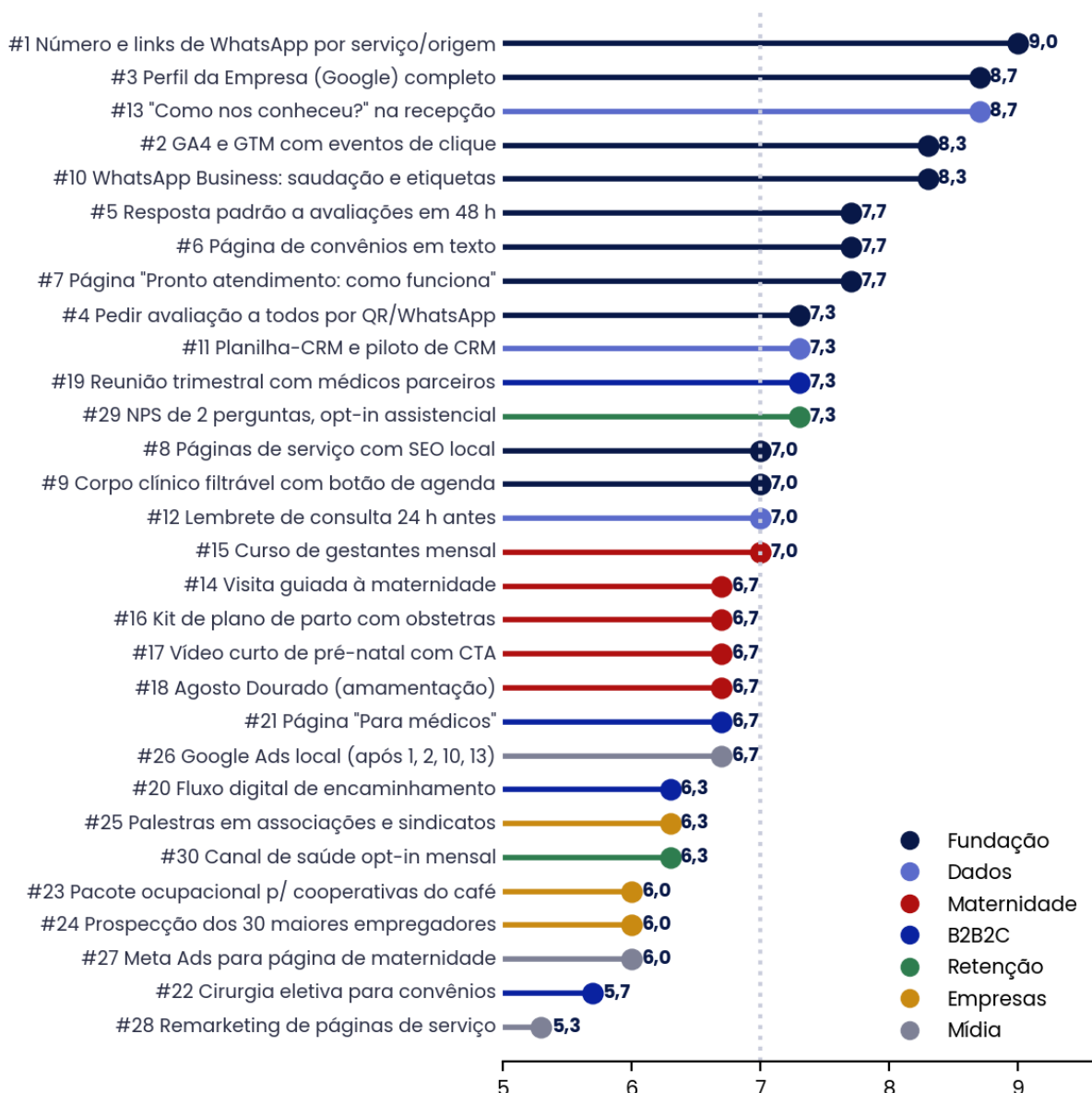


LOOP DE EMPRESAS



Quatro growth loops: a saída de cada etapa alimenta a entrada da seguinte.

Backlog de 30 experimentos (ICE)



Nota ICE (Impact, Confidence, Ease) **[HIPÓTESE]**, recalibrada após 30 dias de dados. Mídia paga só entra depois dos experimentos 1, 2, 10 e 13. Amostra mínima: 30 contatos ou 20 respostas antes de decidir (exceto fundação, binária).

ID	Experimento	Métrica	Prazo	Custo	Encerrar se
1	Números e links de WhatsApp por serviço/origem	% contatos com origem	14 d	R\$ 0 a 300	<80% em 30 d
3	Perfil da Empresa completo	Ligações, rotas, mensagens	30 d	R\$ 0 a 400	Sem crescimento em 60 d
13	"Como nos conheceu?" na recepção	% respondida	14 d	R\$ 0	<70% em 30 d
2	GA4 e GTM com eventos	Eventos/semana	14 d	R\$ 0 a 800	Zerados após 7 d
10	WhatsApp Business: saudação e etiquetas	Tempo da 1ª resposta	14 d	R\$ 0	Sem melhora em 30 d
5	Resposta a avaliações em 48 h	% respondidas	30 d	R\$ 0	<80% em 30 d
6	Página de convênios em texto	Visitas e cliques	30 d	R\$ 500 a 1.500	Sem cliques em 45 d
7	Página "Pronto atendimento: como funciona"	Cliques em rota e telefone	30 d	R\$ 500 a 1.500	<50 cliques em 45 d
4	Pedir avaliação por QR e WhatsApp	Avaliações novas/mês	60 d	R\$ 0 a 300	<15/mês em 60 d
11	Planilha-CRM e piloto	% contatos registrados	30 d	R\$ 0 a 400/mês	<70% em 45 d

ID	Experimento	Métrica	Prazo	Custo	Encerrar se
19	Reunião trimestral com médicos	Médicos presentes	90 d	R\$ 500 a 1.500	<6 médicos em 2 reuniões
29	NPS de 2 perguntas (opt-in)	Respostas e NPS	45 d	R\$ 0 a 300	Resposta <10%
8	Páginas de serviço com SEO local	Impressões e cliques	60 d	R\$ 2.000 a 5.000	Sem impressões em 90 d
9	Corpo clínico filtrável com agenda	Cliques por médico	45 d	R\$ 1.500 a 4.000	<30 cliques em 60 d
12	Lembrete 24 h antes	Taxa de no-show	45 d	R\$ 0 a 200/mês	Sem redução em 60 d

Calendário editorial e reputação

Mês	Tema	Serviço conectado	Cuidado de compliance
Mar	Saúde da mulher e prevenção do câncer do colo do útero	Ginecologia	Informativo, sem promessa de cura
Mai	Maio Amarelo e primeiros socorros	Pronto atendimento e centro cirúrgico	Sem imagens de pacientes
Jun	Junho Vermelho (doação de sangue)	Banco de sangue e parcerias	Dados de doadores protegidos
Ago	Agosto Dourado (amamentação)	Maternidade e pediatria	Revisão clínica do conteúdo
Set	Cuidado do coração e dos rins	Cardiologia e nefrologia	Sem comparação ou ranking
Out	Outubro Rosa	Ginecologia e imagem	Sem sensacionalismo
Nov	Novembro Azul	Urologia	Informativo
Colheita	Saúde do trabalhador rural e check-up [HIPÓTESE de janela]	Saúde ocupacional	Linguagem sem estigma

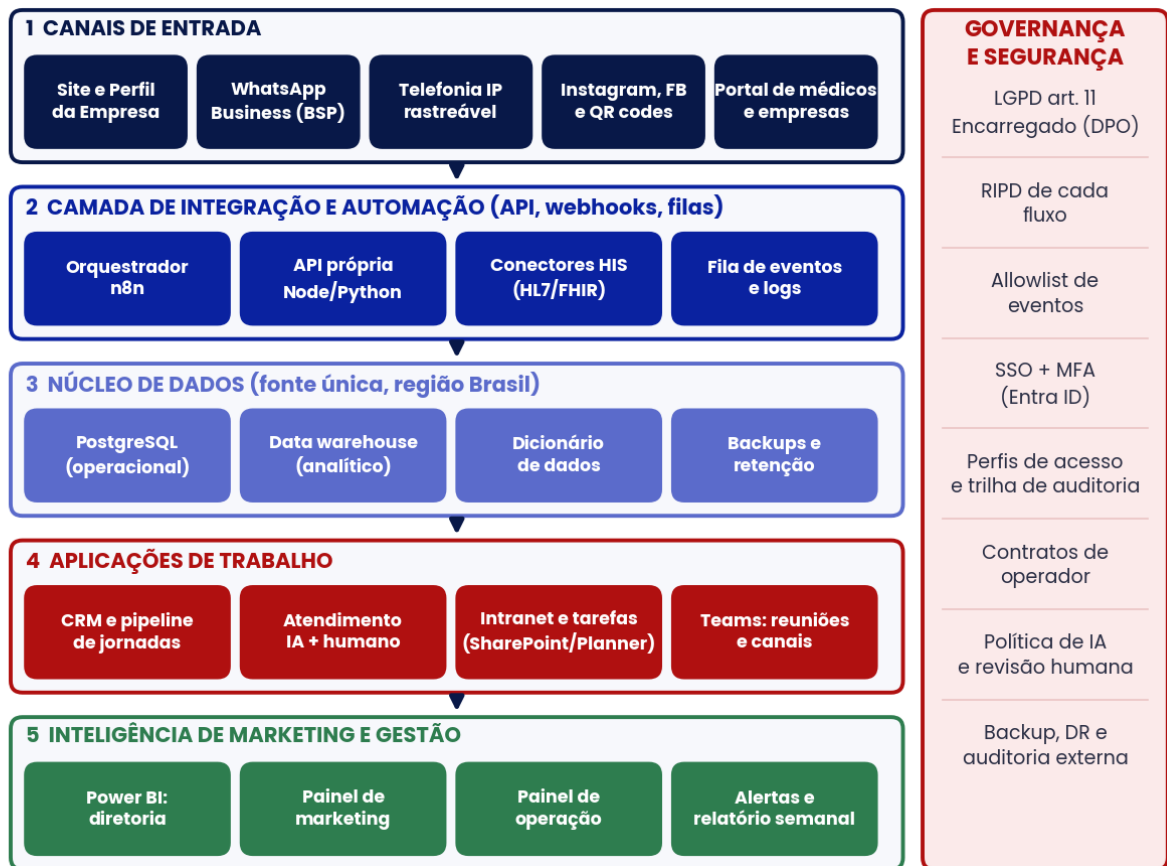
- Programa ético de reputação: pedir avaliação a todos os pacientes, sem incentivo e sem condicionar o atendimento; responder em até 48 horas com texto padrão e canal privado, sem citar dado de saúde nem confirmar vínculo; painéis separados por plataforma (Google, Doctoralia): nunca somar médias.
- B2B2C: metas de 90 dias de 10 médicos em reunião, 3 propostas de apoio cirúrgico, 5 propostas empresariais, lista pública de convênios atualizada e 2 palestras em entidades.

LIVRO 3 | GROWTH | CAPÍTULO 12

Transformação do Ecossistema Digital

TESE

O Ecossistema Digital de Inteligência de Marketing é o ambiente onde informação, dados e comunicação se encontram: canais de entrada alimentam um núcleo de dados único; CRM, atendimento remoto com IA, intranet, tarefas e reuniões trabalham sobre essa base; e o BI entrega à diretoria, em tempo quase real, o retrato do funil, da operação e dos guard-rails. Assim, nenhuma informação relevante deixa de chegar à diretoria e ao setor de Inteligência de Marketing. O programa é executado por um programador fullstack externo, em parceria com a equipe interna.



DIRETORIA, COORDENAÇÃO DE MARKETING E INTELIGÊNCIA: decisões semanais, metas e guard-rails

Arquitetura em cinco camadas, com governança transversal. Toda integração é feita por API e registrada em log.

12.1 Componentes, softwares e como funcionam juntos

Camada	Solução sugerida	Função no ecossistema	Observações
Canais	WhatsApp Business Platform via BSP oficial (ex.: Blip, Zenvia, Twilio ou Gupshup); Google Perfil da Empresa; telefonia IP com número rastreável; site em CMS	Entrada de contatos com origem e intenção registradas desde o primeiro clique	Cotar BSPs; tarifas de referência: utilidade ≈ R\$ 0,04-0,05 e marketing ≈ R\$ 0,31-0,38 por mensagem; serviço dentro de 24 h sem custo em 2026 [BENCHMARK, confirmar na Meta]
Integração	n8n (orquestração) + API própria em Node/Python + fila de eventos	Conecta canais, banco, CRM, agenda e IA; webhooks gravam cada evento	n8n Cloud a partir de € 20/mês [BENCHMARK] ; alternativa self-hosted

Camada	Solução sugerida	Função no ecossistema	Observações
Núcleo de dados	PostgreSQL gerenciado em região Brasil (AWS São Paulo, Azure Brazil South ou Google Cloud São Paulo) + camada analítica	Fonte única: contato, origem, intenção, consentimento, histórico administrativo; sem dado clínico	Backups, retenção, dicionário de dados e trilha de auditoria desde o dia 1
CRM	Fase 1: RD Station CRM (Basic R\$ 65,70 ou Pro R\$ 117,90 por usuário/mês) ou HubSpot Free; Fase 2: módulos próprios sobre o banco, feitos pelo programador	Pipeline por jornada (consulta, cirurgia, internação, maternidade, B2B), etiquetas e SLA da 1ª resposta	Preços pesquisados em 02/10/2026; confirmar antes de contratar
Atendimento remoto com IA	Assistente virtual no WhatsApp com modelo de linguagem via API (ex.: Claude, da Anthropic) e RAG sobre base pública aprovada; handoff humano	Responde horários, convênios, preparo, curso de gestantes e agendamento administrativo, 24 horas	Sem diagnóstico, triagem nem dado de saúde nos prompts; contrato de operador, RIPD e revisão humana
Intranet, tarefas e reuniões	Microsoft 365: SharePoint (intranet), Teams (canais por setor e reuniões), Planner e Power Automate (tarefas e rotinas), Entra ID (SSO + MFA)	Comunicação integrada entre setores; tarefas ligadas a eventos do CRM; documentos e indicadores por setor	Licenciamento a cotar; alternativa de tarefas: ClickUp (US\$ 7 por usuário/mês) ou Trello
BI e dashboards	Power BI (conectado ao banco por DirectQuery e streaming) com Looker Studio como apoio gratuito; GA4, GTM e Search Console como fontes	Painéis em três camadas, atualizados a cada 5 a 15 minutos; alertas de guard-rails	Preço de licença a cotar; "tempo real" significa atualização quase contínua
Integração com sistema hospitalar	Conectores REST, HL7/FHIR ou arquivos, conforme o sistema vigente (HIS/ERP)	Agenda, comparecimento, convênio e valor entram no CRM sem dado clínico	Mapear o fornecedor na oficina 3
Governança e segurança	Encarregado (DPO), RIPD, política de IA, contratos de operador, gerenciador de senhas, auditoria externa	Garante conformidade com LGPD art. 11 e Resolução CFM 2.336/2023	Nenhuma ferramenta é integrada sem inventário, contrato e aprovação formal

12.2 Jornada de um contato dentro do ecossistema

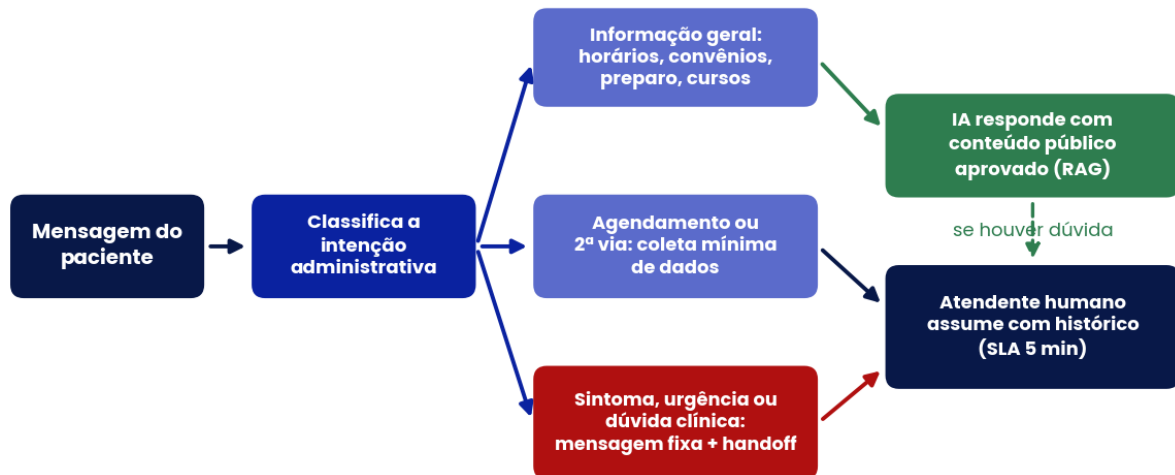
Cada etapa gera um evento no banco de dados e alimenta o CRM e o painel da diretoria



Oito etapas; cada uma gera um evento no banco, alimenta o CRM e atualiza o painel da diretoria.

12.3 Atendimento remoto com IA

Regras de ouro: sem diagnóstico nem triagem clínica; sem dado de saúde nos prompts; assistente identificado como virtual



Fluxo do assistente virtual: responde apenas conteúdo administrativo aprovado; qualquer dúvida clínica ou urgência segue mensagem fixa e passa a um humano.

- Horário: assistente 24 h para informação e pré-agendamento; humanos em horário comercial com SLA de 5 min (15 min fora dele).
- Conhecimento: base pública aprovada (serviços, horários, convênios com data, preparo de exames, curso de gestantes), versionada pela coordenação.
- Medição: % resolvido sem humano, taxa de handoff, satisfação e temas de dúvida, tudo em dados agregados.

12.4 Intranet, tarefas e comunicação entre setores

Teams (canais e reuniões) | SharePoint (documentos e indicadores) | Planner (tarefas)



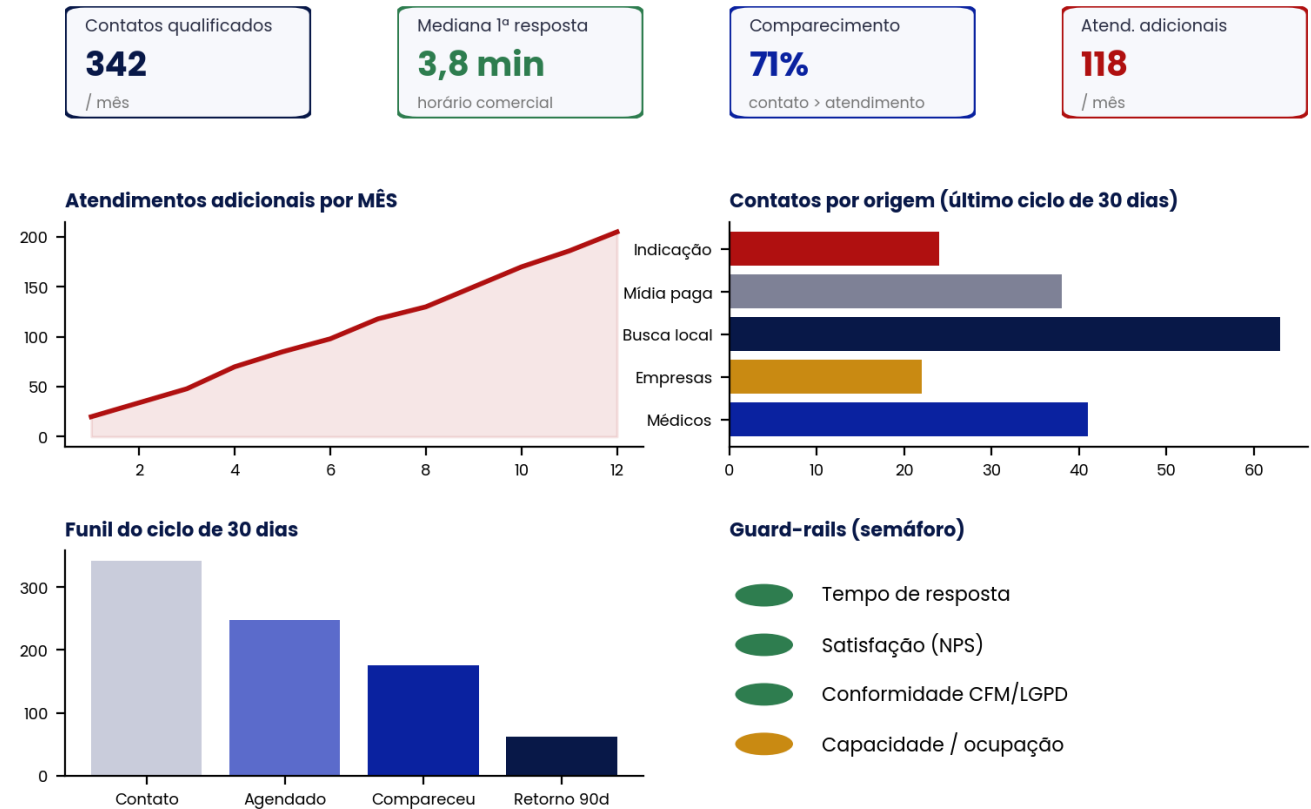
Todos os setores se conectam ao núcleo de dados; Teams, SharePoint e Planner são a camada de trabalho cotidiano.

Ferramenta	Uso diário	Ligação com dados
Teams	Um canal por setor e por projeto; reunião semanal de funil; plantão de dúvidas	Alertas do CRM e do BI postados automaticamente nos canais
SharePoint (intranet)	Políticas, scripts, playbooks, calendário editorial, biblioteca de marca	Indicadores do setor incorporados do Power BI

Ferramenta	Uso diário	Ligação com dados
Planner e Power Automate	Quadro de tarefas por setor; ciclo de 30 dias; lembretes	Um lead sem resposta em 5 min cria tarefa e avisa o responsável

12.5 Painéis para a diretoria

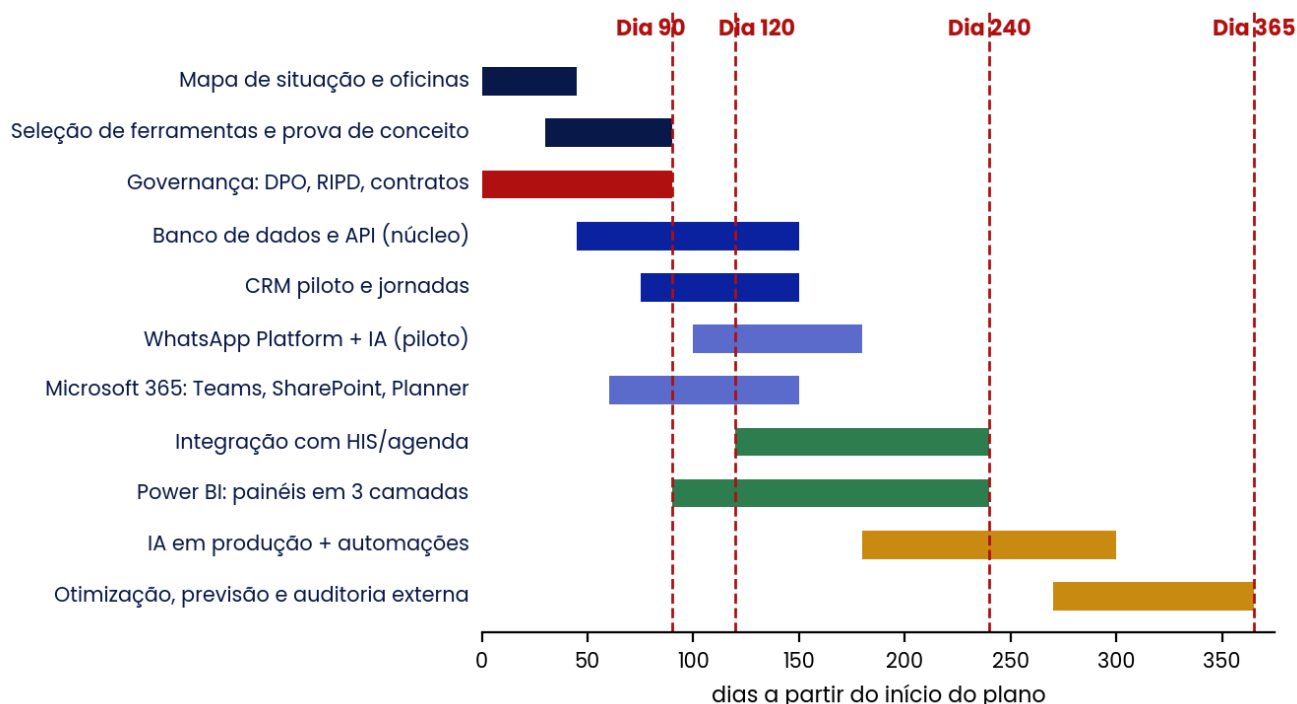
Painel da diretoria (EXEMPLO ILUSTRATIVO com dados fictícios)



Exemplo ilustrativo com dados fictícios: o painel real será definido na oficina de indicadores.

Camada	Público	Conteúdo	Atualização
Diretoria	Sócios e direção clínica	North Star, TRJA, atendimentos adicionais /mês, guard-rails, custo por atendimento, projeção de caixa em ciclos de 30 dias	Quase contínua; resumo semanal
Marketing e inteligência	Coordenação e time	Origem, conversão por etapa, campanhas, conteúdo, reputação, experimentos ICE	Diária
Operação	Recepção, enfermagem, faturamento	Tempo de resposta, fila, no-show, lembretes, capacidade	A cada 15 minutos

12.6 Plano de implantação: 90, 120, 240 dias e 1 ano



Cronograma de implantação do ecossistema. As fases se sobrepõem de propósito para encurtar o prazo.

Fase	Entregas	Reuniões e decisões	Critério de saída
Dias 1-90 Fundação e escolha	Oficinas: (1) mapa de situação, (2) jornadas e indicadores, (3) dados, sistemas e LGPD, (4) seleção de ferramentas; DPO nomeado; RIPD v1; prova de conceito de 2 CRMs e 2 BSPs; contrato do programador; banco de dados e API (núcleo) iniciados; Microsoft 365 configurado; planilha-CRM no ar	Comitê quinzenal; decisão de ferramentas até o dia 60; contratos de operador até o dia 75	Ferramentas contratadas; ≥90% dos contatos com origem; núcleo de dados em homologação
Dias 91-120 Integração	CRM piloto com jornadas; WhatsApp Platform + assistente de IA em piloto (FAQ administrativa); eventos do site no banco; intranet com 2 setores; primeiros painéis Power BI	Revisão de gates (semana 12-16); treinamento por setor	Piloto com 1ª resposta ≤5 min e handoff funcionando; sem incidente de dados
Dias 121-240 Escala	Integração com HIS/agenda; painéis em 3 camadas; lembrete 24 h e NPS automáticos; intranet em todos os setores; Planner ligado ao CRM; IA em produção para FAQ e agendamento administrativo	Oficina de indicadores 2; revisão trimestral de OKRs	Painel da diretoria em uso semanal; no-show em queda; adoção ≥80%
Dias 241-365 Otimização	Previsão de no-show e demanda com dados agregados; automações por jornada; auditoria externa de segurança; documentação completa; transferência de conhecimento; plano do ano 2	Revisão anual; decisão sobre módulos próprios de CRM	Maturidade 4; auditoria concluída; documentação e repositório sob guarda do hospital

Trilha de maturidade digital: nível-alvo (0 a 5)

	Dia 90	Dia 240	Dia 365
Dados e analytics	2	3	4
CRM e relacionamento	2	3	4
Automação	1	2	3
Conteúdo	2	3	4
Gestão de equipe e projetos	2	3	4
IA aplicada	1	2	3
Segurança e LGPD	2	3	4

Trilha de maturidade por camada.

Critérios de seleção de ferramentas (pesos)

Critério	Peso	Como verificar
Conformidade LGPD (contrato de operador, hospedagem, logs)	25%	Questionário e contrato
API aberta e integração com WhatsApp, banco e BI	20%	Prova de conceito
Custo total em 12 meses	15%	Cotação por escopo
Suporte local e facilidade de uso pela equipe	15%	Teste com recepção
Escalabilidade e roadmap do fornecedor	15%	Referências
Portabilidade dos dados (exportação, propriedade)	10%	Cláusula contratual

LIVRO 3 | GROWTH | CAPÍTULO 13

Equipe interna de marketing: recrutamento, seleção e treinamento

TESE

O plano internaliza a inteligência e a produção de marketing. A equipe é composta por coordenação, social media, designers gráficos, filmmaker, editor e analista de dados e CRM; o único profissional externo é o programador fullstack, responsável por CRM, dashboards, integrações e IA. A contratação é escalonada, com gates, para que a estrutura cresça no ritmo dos resultados. Coordenação e analista de dados são recomendações do plano para sustentar a gestão e o uso dos dados.



Estrutura-alvo da equipe de marketing e inteligência.

Cargo	Missão e entregas	Faixa salarial /mês [HIPÓTESE]	Início
Coordenador(a) de Marketing e Inteligência	Estratégia, OKRs, orçamento, relação com médicos e empresas, governança de marca, liderança do time e do processo seletivo	R\$ 7.000 a 10.000	Mês 2
Social media e community manager	Calendário editorial, publicação, comunidade, reputação, atendimento em redes, relatórios	R\$ 2.800 a 4.200	Mês 3
Designer gráfico (1)	Brand book, peças, sinalização, materiais impressos e digitais, templates	R\$ 3.200 a 4.800	Mês 3
Filmmaker	Captação de vídeo e foto, cobertura de eventos, institucional, depoimentos autorizados (TCLE)	R\$ 3.500 a 5.500	Mês 4
Editor(a) de vídeo	Edição, motion, cortes para redes, legendas, acervo	R\$ 3.000 a 4.800	Mês 4
Analista de dados e CRM	Modelagem de dados, indicadores, painéis, ritos semanais, qualidade do CRM, interface com o programador	R\$ 4.500 a 7.000	Mês 5
Designer gráfico (2) [gate]	Reforço de produção quando o gate de volume for atingido	R\$ 3.200 a 4.800	Mês 8
Programador fullstack (externo, PJ)	CRM, banco de dados, API, dashboards, integrações de IA e segurança; documentação e transferência	R\$ 9.000 a 16.000 de retainer	Mês 1

Custo total do empregador estimado em 1,7 vez o salário (encargos, benefícios e provisões) [HIPÓTESE]; valores a validar com o RH e o mercado local.

13.1 Recrutamento e seleção

Processo seletivo padrão por vaga: cerca de 40 dias do alinhamento do perfil à oferta [HIPÓTESE]



Processo seletivo padrão, repetido para cada vaga.

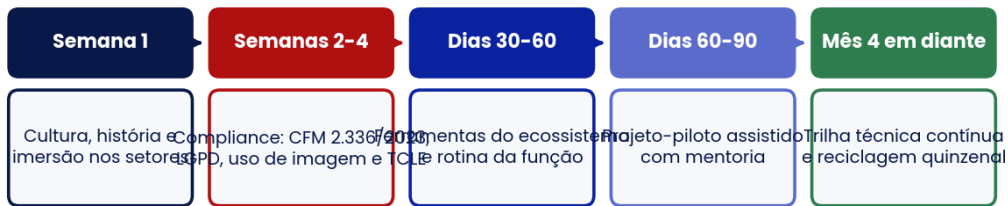
Etapa	O que acontece	Instrumento
1 Perfil	Descrição do cargo, competências, indicadores e faixa; aprovação da diretoria	Scorecard do cargo
2 Divulgação	LinkedIn, instituições de ensino superior e técnico da região, indicação interna, grupos profissionais	Texto padrão alinhado à voz da marca
3 Triagem	Portfólio e aderência; resposta a todos os candidatos	Rubrica de 1 a 5
4 Teste prático remunerado	Briefing real: ex. roteiro, captação e edição de 60 s sobre o curso de gestantes (com roteiro e sem pacientes)	Rubrica de resultado e processo
5 Entrevista e painel	Competências, valores e ética com coordenação, diretor-sócio e enfermagem	Roteiro estruturado
6 Referências e oferta	Duas referências; proposta com plano de desenvolvimento	Checklist de contratação
7 Onboarding	Plano 30-60-90 e padrinho/madrinha	Plano individual

Critério de avaliação	Peso
Qualidade técnica do portfólio e do teste prático	35%
Comunicação e sensibilidade para saúde, ética e uso de imagem	20%
Organização, prazo e trabalho em equipe	20%
Aderência à voz e aos valores da marca	15%
Potencial de crescimento e aprendizado	10%

Seleção do programador fullstack (externo)

- Perfil: Node.js ou Python, PostgreSQL, APIs REST e webhooks, Power BI ou BI equivalente, integrações com WhatsApp Business Platform, noções de HL7/FHIR e LGPD.
- Desafio técnico: integrar um webhook de WhatsApp a um banco PostgreSQL, com registro de origem e intenção e sem dado pessoal em logs.
- Contrato: propriedade do código e dos dados do hospital, repositório e nuvem em conta do hospital, NDA, contrato de operador LGPD, SLA, documentação obrigatória, revisão de código por segundo profissional e cláusula de transição.
- Mitigação de dependência: documentação viva, ambiente de homologação e o analista de dados interno como contraparte técnica.

13.2 Treinamento e desenvolvimento



Avaliações: checkpoint 30-60-90 dias, ciclo de OKRs trimestral, feedback 1:1 quinzenal, plano de desenvolvimento individual semestral

Trilha de integração e desenvolvimento do time de marketing.

Trilha	Conteúdo	Público	Frequência
Compliance	CFM 2.336/2023, Manual de Publicidade Médica, LGPD, TCLE, direito de imagem	Todo o time	Semana 2-4 e reciclagem semestral
Marca e voz	Brand book, guia de linguagem, redação para saúde	Todo o time e recepção	Dias 1-30 e trimestral
Ferramentas	Teams, SharePoint, Planner, CRM, WhatsApp, Power BI	Todo o time; setores do hospital por turno	Dias 30-60; treinamento quinzenal de 45 min nas primeiras 12 semanas
Técnica	Audiovisual hospitalar, design de sistemas visuais, social media em saúde, SEO local, análise de dados	Por função	Mensal; orçamento de capacitação
Liderança	OKRs, gestão de projetos, feedback	Coordenação	Trimestral

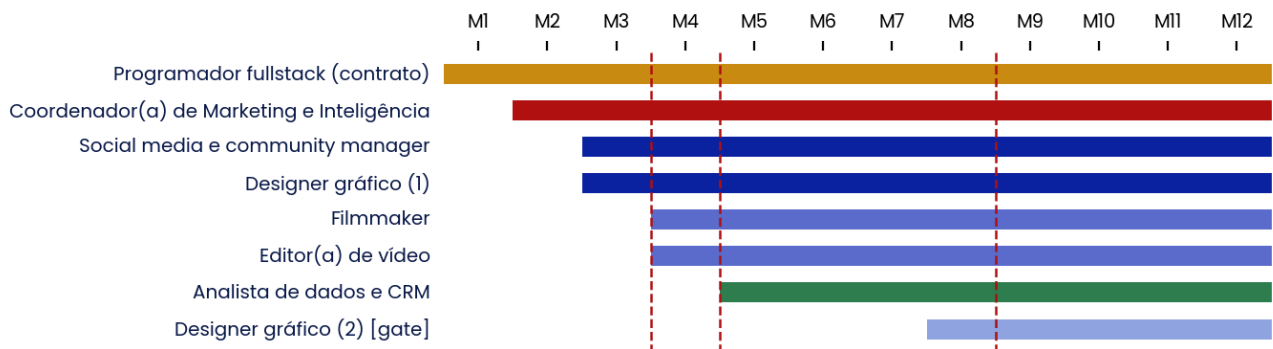
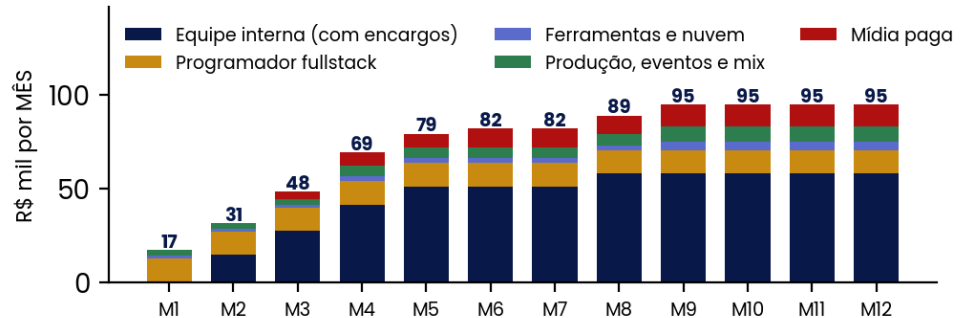
Adoção no hospital: patrocinador na direção, campeões na recepção, enfermagem e faturamento, playbooks e scripts na intranet e métricas por equipe. Rituais: diário de 15 minutos nas 4 primeiras semanas, semanal de 45 minutos (funil, gargalos, avaliações), mensal de resultados e riscos e trimestral de OKR.

LIVRO 3 | GROWTH | CAPÍTULO 14

Orçamento, OKRs, calendário e riscos

TESE

Com equipe interna, a maior parte do investimento passa a ser capacidade permanente (pessoas, sistemas e produção), e não contratos de agência. O orçamento abaixo é apresentado por mês (ciclo de 30 dias), com a escala de contratações e o ponto de equilíbrio. Todos os parâmetros são **[HIPÓTESE]** a calibrar após 60 dias.

Escala de contratação (mês de início do contrato)**Custo recorrente mensal, cenário base [HIPÓTESE]**

Escala de contratação e custo recorrente por mês (cenário base). Valores em R\$ mil por mês.

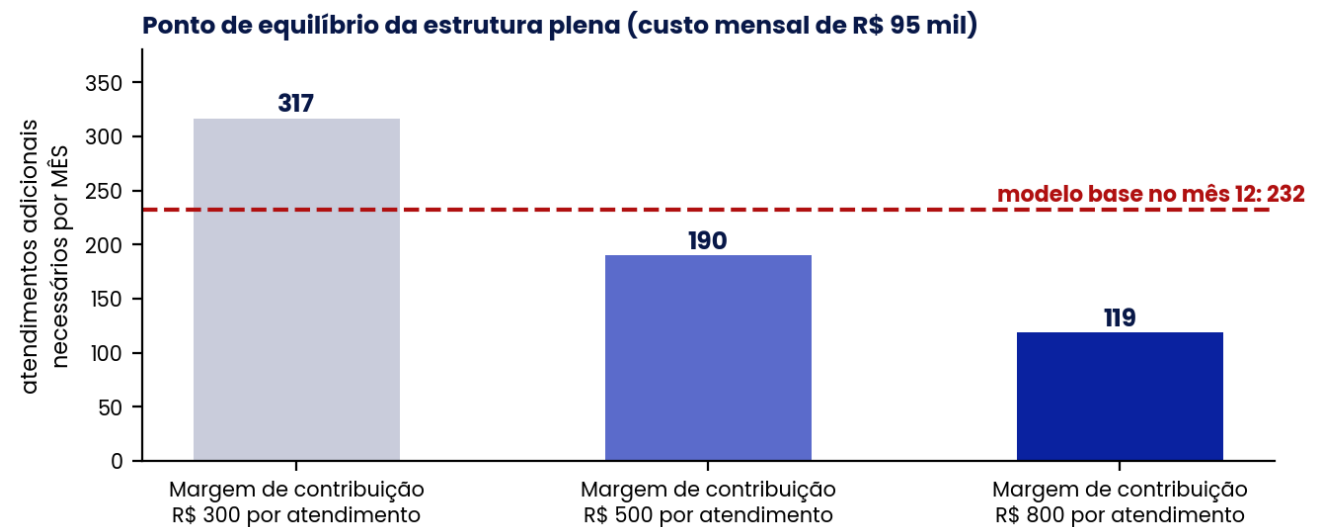
Mês	Pessoas	Programador	Ferramentas	Produção e mix	Mídia	Total /mês
M1	R\$ 0	R\$ 12.500	R\$ 1.500	R\$ 3.000	R\$ 0	R\$ 17.000
M3	R\$ 27.200	R\$ 12.500	R\$ 1.500	R\$ 3.000	R\$ 4.000	R\$ 48.200
M4	R\$ 41.480	R\$ 12.500	R\$ 2.500	R\$ 6.000	R\$ 7.000	R\$ 69.480
M6	R\$ 51.255	R\$ 12.500	R\$ 2.500	R\$ 6.000	R\$ 10.000	R\$ 82.255
M8	R\$ 58.055	R\$ 12.500	R\$ 2.500	R\$ 6.000	R\$ 10.000	R\$ 89.055
M12	R\$ 58.055	R\$ 12.500	R\$ 4.500	R\$ 8.000	R\$ 12.000	R\$ 95.055

Resumo em 12 meses	Valor
Custo recorrente acumulado (soma dos 12 ciclos de 30 dias)	R\$ 879.170
Dias 1 a 90 (meses 1-3)	R\$ 96.650
Dias 91 a 120 (mês 4)	R\$ 69.480
Dias 121 a 240 (meses 5-8)	R\$ 332.820
Dias 241 a 365 (meses 9-12)	R\$ 380.220

Resumo em 12 meses	Valor
Investimento pontual de implantação (uma vez)	R\$ 110.000 a R\$ 235.000

Investimentos pontuais [HIPÓTESE, cotar]

Item	Faixa
Kit audiovisual (câmeras, lentes, áudio, iluminação, estabilizador)	R\$ 35.000 a R\$ 60.000
Duas estações de edição e design	R\$ 18.000 a R\$ 30.000
Refresh de marca, brand book e sinalização (produção gráfica)	R\$ 15.000 a R\$ 40.000
Site/CMS: nova arquitetura e páginas de serviço	R\$ 10.000 a R\$ 35.000
Nuvem, segurança, jurídico/LGPD e auditoria inicial	R\$ 15.000 a R\$ 35.000
Recrutamento, assessment e onboarding	R\$ 4.000 a R\$ 9.000
Treinamento e capacitação (12 meses)	R\$ 8.000 a R\$ 16.000
Pesquisa primária (entrevistas, enquete, painel)	R\$ 5.000 a R\$ 10.000



Quanto atendimentos adicionais por mês pagam a estrutura plena, conforme a margem de contribuição por atendimento (valores ilustrativos até o hospital informar a margem real).

GATES DE ESCALA E CONTRATAÇÃO

Avançar de conservador para base se, por 60 dias, a mediana de 1ª resposta ficar em até 5 minutos, 90% dos contatos tiverem origem registrada e o custo por contato qualificado estiver até 20% acima da premissa. Avançar para agressivo apenas com capacidade confirmada e margem por linha conhecida. O 2º designer e o aumento de mídia acima de R\$ 10 mil/mês só são liberados com gates verdes. Regra de custo de aquisição: o custo por atendimento não deve passar de 10 a 15% da margem de contribuição da linha [BENCHMARK, a calibrar].

OKRs dos primeiros 12 meses

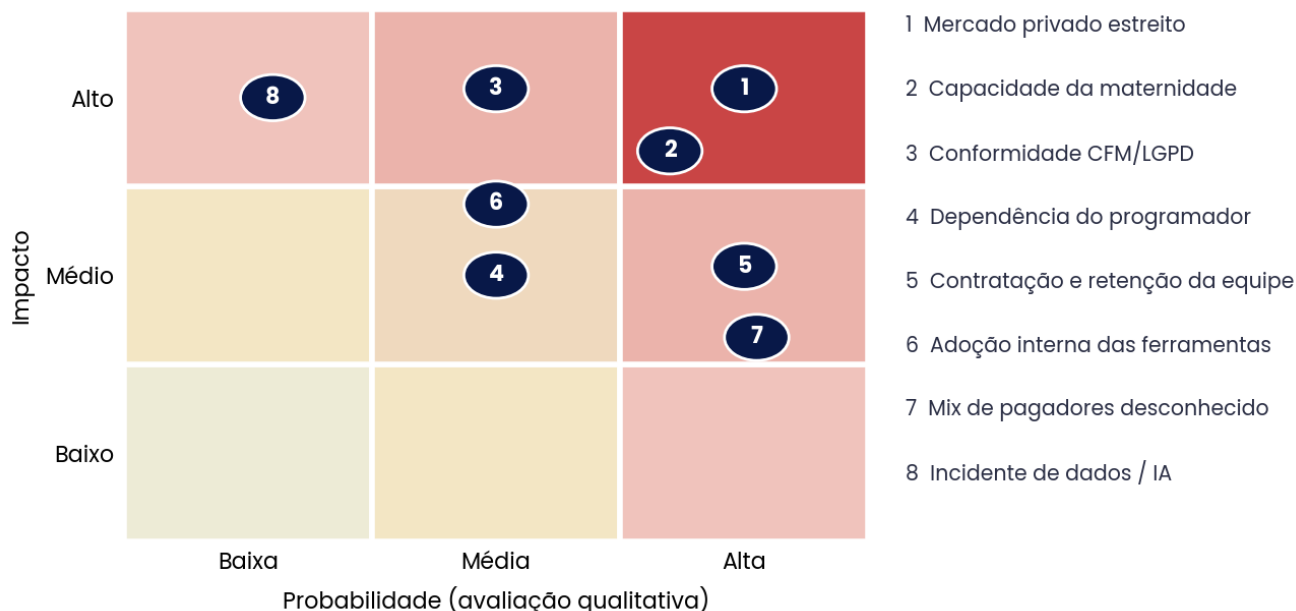
Objetivo	Resultados-chave [RECOMENDAÇÃO; baseline medido nos 30 primeiros dias]
01. Fundação de captura e dados	KR1: 100% dos canais com número e CTA por intenção até o dia 30. KR2: 90% dos contatos com origem até o dia 60. KR3: 1ª resposta com mediana ≤5 min em horário comercial até o dia 90.
02. Marca e linguagem únicas	KR1: brand book v1 até o dia 90 e v2 até o dia 365. KR2: 100% das peças com checklist CFM/LGPD. KR3: scorecard de marca de 5,7 para 7,5 em 12 meses.
03. Casa de famílias da Região Café	KR1: 100 gestantes com contato em 90 dias. KR2: 3 turmas do curso de gestantes em 240 dias. KR3: 15 entrevistas do ICP-1.
04. Rede de médicos e empresas	KR1: 10 médicos parceiros em reunião em 90 dias. KR2: 5 propostas empresariais em 120 dias. KR3: lista de convênios atualizada todo mês.

Objetivo	Resultados-chave [RECOMENDAÇÃO; baseline medido nos 30 primeiros dias]
05. Ecossistema digital	KR1: núcleo de dados e CRM piloto até o dia 120. KR2: painel da diretoria em uso semanal até o dia 240. KR3: auditoria externa concluída até o dia 365.
06. Equipe interna	KR1: coordenação contratada até o mês 2 e núcleo (social, design, filmmaker, editor) até o mês 4. KR2: 100% do time com trilha de compliance concluída em 60 dias. KR3: rotatividade ≤10% em 12 meses.
07. Crescimento	KR1: ≥38 atendimentos adicionais por mês no mês 4 (base). KR2: ≥150 no mês 8. KR3: ≥230 no mês 12, com guard-rails verdes.

Calendário de 7, 30, 90, 120, 240 e 365 dias

Horizonte	Dono sugerido	Resultado esperado
7 dias	Diretor-sócio e marketing	Patrocinador e encarregado nomeados; um número por intenção; planilha de pagadores; vagas abertas
30 dias	Marketing e TI	Origem registrada; eventos no GA4; política atualizada; oficinas 1 e 2; coordenação em seleção
90 dias	Marketing e direção clínica	Brand book v1; ferramentas escolhidas; núcleo de dados; primeiras jornadas qualificadas; gates verdes
120 dias	Marketing e programador	CRM e IA em piloto; curso de gestantes; propostas empresariais; time central completo
240 dias	Marketing e dados	Integração com agenda; painéis em 3 camadas; redução de no-show; mídia em escala
365 dias	Direção e TI	Funil medido ponta a ponta; maturidade 4; auditoria externa; plano do ano 2

Riscos, pre-mortem e red team



Matriz de riscos [RECOMENDAÇÃO].

Risco	Mitigação
1 Mercado privado estreito	Convênios corporativos, alcance regional, mix de pagadores em 7 dias
2 Capacidade da maternidade	Checagem semanal de capacidade; gate de mídia
3 Conformidade CFM/LGPD	Fluxo de revisão, DPO, RIPD, política de IA
4 Dependência do programador	Contrato com propriedade do código, documentação, revisão cruzada, analista de dados interno

Risco	Mitigação
5 Contratação e retenção	Processo estruturado, plano de carreira, contratação por gates
6 Adoção interna	Campeões por setor, treinamento quinzenal, simplificação de campos
7 Mix de pagadores desconhecido	Planilha de pagadores no dia 7; metas só após receber
8 Incidente de dados / IA	Allowlist de eventos, SSO + MFA, auditoria externa, revisão humana

PRE-MORTEM: EM 12 MESES O PLANO FALHOU PORQUE...

(1) a diretoria não definiu patrocinador e metas; (2) a mídia foi ligada antes da instrumentação; (3) o hospital não tinha capacidade para a demanda gerada; (4) uma peça sem revisão gerou advertência do CRM; (5) dado de saúde foi parar em ferramenta sem contrato; (6) o conhecimento ficou concentrado em uma só pessoa. Mitigação: patrocinador nomeado no dia 7; gates de mídia; checagem semanal de capacidade; fluxo de revisão; política de IA e dados; documentação e backup de função.

FECHAMENTO

Conclusão e decisões pedidas

TESE

O Hospital e Maternidade São Paulo tem décadas de confiança, médicos sócios, corpo clínico identificado e um símbolo reconhecível. Com marca e linguagem unificadas, uma equipe interna dedicada, canais com médicos e empresas e um ecossistema digital que integra dados, CRM, IA, intranet e BI, terá uma vantagem que o concorrente não copia em uma semana.

Decisões pedidas à direção

- Nomear o patrocinador do plano e o encarregado de dados; liberar acesso ao domínio, ao Perfil da Empresa e às redes.
- Entregar em 7 dias a planilha de pagadores, capacidade e produção dos últimos 12 meses, por ciclo de 30 dias (sem dado pessoal).
- Aprovar a estrutura de equipe em ondas (coordenação e programador no mês 1) e o orçamento dos primeiros 90 dias, com revisão dos gates na semana 12.
- Validar a data de fundação e a narrativa histórica oficial.

O QUE ESTÁ DECIDIDO

Quatro apostas, uma lista do que não fazer, plano diretor com horizontes de 90, 120, 240 e 365 dias, 30 experimentos priorizados, arquitetura do ecossistema, processo de recrutamento e governança de dados e IA.

O QUE DEPENDE DA DIRETORIA

Patrocinador, mix de pagadores, capacidade, margem por linha, sistema hospitalar vigente, aprovação do encarregado LGPD e orçamento das contratações.

Anexo A: Plano de pesquisa primária (30 dias)

Ação	Amostra e método	Responsável	Resultado esperado
Entrevistas curtas	15 a 25 pessoas (8 gestantes ou mães recentes, 6 adultos 40+, 4 empresas, 5 médicos); 8 a 12 min, sem áudio, vídeo ou dado clínico; consentimento e anonimização	Marketing	Critérios de escolha, objeções e linguagem real
Enquete de 5 perguntas	Recepção, 60 a 120 respostas voluntárias; sem inferência para toda Cacoal	Recepção	Origem, motivo e satisfação
QR code de origem	Cartazes e comprovantes com QR por serviço	Marketing	Mapa de canais
Perguntas frequentes	Análise de telefone e WhatsApp por 30 dias, sem dado pessoal	Recepção e marketing	FAQ e scripts
Avaliações públicas	100 avaliações do Maps e 30 posts	Marketing	Scorecard recalibrado

Anexo B: Lacunas e perguntas pendentes

- Google Maps, Instagram, Facebook e Reclame Aqui do hospital e dos concorrentes privados: coleta manual guiada **[SEM ACESSO]**.
- CNES do hospital e dos concorrentes: reverificar; capacidade real pela diretoria clínica.
- SINASC por município de Cacoal e Região Café; cobertura de planos no ANS TabNet; SIH por causas de internação: coletar no DATASUS.
- Mix de pagadores, ocupação, margem por linha, produção e agenda: dados internos, em 7 dias.
- Anúncios ativos dos concorrentes na Biblioteca de Anúncios da Meta e no Google.
- Normas de publicidade médica e políticas de plataformas: revisar o texto vigente com responsável técnico e jurídico.
- Salários, licenças e preços de ferramentas: cotar localmente antes de contratar.

Anexo C: Livro de evidências e memória de cálculo

Fonte	O que foi extraído
Site do hospital, 02/10/2026	Serviços, 33 especialidades, corpo clínico com CRM/RQE, fundação em 1975, ampliações de 1983 e 1996
CNES 2784637	Hospital geral, 23 leitos existentes (competência a confirmar)
IBGE Cidades e Censo 2022; IFRO; Registro Civil	População, faixas etárias, PIB per capita, mortalidade infantil, nascidos vivos de RO (24.738 em 2022)
SESAU/RO (planos regionais, RDQA)	Macro II com 735.852 hab. (IBGE 2022), 34 municípios e regiões de saúde
SINASC/DATASUS	RO: 23.830 (2023), 21.518 (2024), 20.227 (2025); Cacoal 2024: 1.258 residentes e 1.798 ocorridos
ANS	Cobertura de 25,37% no Brasil (nov/2024); Cacoal ≈10,4% e 10.155 beneficiários
Sebrae/RO; Receita Federal; Angels Initiative	Hospitais privados da praça
INPI e Lei 5.958/2025	IG Matas de Rondônia e Rota do Café
Páginas de preço de ferramentas, 02/10/2026	RD Station, Zoho, ClickUp, Trello, Looker, n8n, WhatsApp Business Platform (benchmark)
Geodados municipais de RO (GeoJSON público)	Base dos mapas deste documento

Memória de cálculo. (1) Natalidade RO = $24.738 / 1.581.196 = 15,65$ por mil. (2) Área primária = $86.887 + 6.466 = 93.353$; secundária = $35.079 + 29.414 + 56.406 = 120.899$; alcance ativo = 214.252 (29,1% de 735.852). (3) Acesso privado = plano (8, 11, 14%) + particular (4, 6, 8%) **[HIPÓTESE]**. (4) SAM-1 = TAM x acesso; SAM-2 = SAM-1 x 29,1%. (5) SOM = SAM-2 x captura (6, 10, 15%). (6) Equivalente mensal = valor anual / 12. (7) Modelo de crescimento: ver capítulo II e script de parâmetros; custo de pessoal = salário médio x 1,7. (8) Orçamento: média / custo por contato x conversão.

LIMITES DO DOCUMENTO

Este plano não substitui parecer jurídico (publicidade médica, LGPD, contratos), avaliação clínica, auditoria de segurança da informação nem validação financeira, e não autoriza publicação, contratação, integração de sistemas ou compra de mídia sem aprovação formal. Estimativas e hipóteses estão rotuladas e serão recalibradas com dados internos e pesquisa primária.

Cuidado de família, gestão de hospital.

www.hmsaopaulo.com.br | Cacoal, Rondônia